



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Lima 22 de julio del 2025

CARTA N°0032FM-EPE-FM-2025

Dr.

PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE

Director

DIRIS LIMA CENTRO

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle y a la vez, manifestarle que la estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería:

- **Srta. Yemmy Eliane Santos Chinguel**, identificada con número de matrícula N° 20010462

La cual viene desarrollando su proyecto de investigación:

- **"Efectividad del Programa de consejería "Lactancia de amor" en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones, Lima - Perú, 2025."**

En tal sentido, se solicita muy amablemente brinde usted o autorice a quien corresponda las facilidades necesarias para que la mencionada estudiante pueda recolectar información y aplicar su instrumento durante los meses de julio a octubre del 2025.

Sin otro particular y agradeciéndole anticipadamente por todas las facilidades que brinde, me despido de usted.

Muy Atentamente.

.....
DRA. ANGELA ROCIO CORNEJO VALDIVIA

Directora

Escuela Profesional de Enfermería

UNMSM



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0234-2025

En Lima, a los quince días del mes de agosto, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Investigación titulado: **"Efectividad del programa de consejería "Lactancia de amor" en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones, Lima – Perú, 2025"** presentada por **Yemmy Eliane Santos Chinguel** con código 20010462, de la escuela profesional de enfermería, proyecto de investigación para ser ejecutado, en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 14 de agosto de 2026"

Lima, 15 de agosto de 2025




JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I./F.M./U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CÓDIGO DOCENTE: 0A3079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415
Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra
Presidente del CEI/FM/UNMSM

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería



Efectividad del Programa de consejería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025

Proyecto de Investigación

AUTORA

Bach. SANTOS CHINGUEL Yemmy Eliane

ASESORA

Dra. ESPINOZA MORENO Tula Margarita

Lima – Perú

2025

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.....	3
1.1. Planteamiento del problema.....	3
1.2. Objetivos.....	5
1.3. Justificación de la investigación.....	6
1.4. Limitaciones del estudio.....	6
CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS.....	6
2.1. Marco teórico.....	6
2.2. Formulación de hipótesis.....	25
2.3. Metodología.....	26
2.3.1. Tipo, método y diseño de la investigación.....	26
2.3.2. Población.....	26
2.3.3. Tamaño de muestra.....	26
2.3.4. Selección de muestra.....	26
2.3.5. Variables.....	27
2.3.6. Operacionalización de variables.....	27
2.3.7. Técnicas e instrumentos.....	28
2.3.8. Plan de recolección, procesamiento y análisis de datos.....	28
2.3.9. Consideraciones éticas. Consentimiento informado.....	30
CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	32
3.1. Cronograma de trabajo.....	32
3.2. Presupuesto.....	32
3.3. Recursos disponibles.....	33
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	34
ANEXOS.....	40
Matriz de consistencia del Proyecto.....	1
Instrumento.....	1
Cálculo de Coeficiente de Validez de Contenido.....	7
Formato de consentimiento informado.....	8

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), la lactancia materna (LM) es una forma eficaz de brindar seguridad en la salud alimentaria de los niños porque es limpia, contiene anticuerpos que protegen a los lactantes de muchas enfermedades, junto a la energía y nutrientes necesarios. En entrevista realizada a una nutricionista de la Dirección Regional de Salud e integrante de la Estrategia de Alimentación y Nutrición Saludables (ESANS), refiere que la leche materna presenta componentes como proteínas, vitaminas, minerales, inmunoglobulinas, factores de crecimiento, etc. que benefician el crecimiento y desarrollo físico, mental e inmunológico (2)

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (3), la LM ofrece múltiples beneficios tanto para el lactante como para la madre. Para el bebé, destaca su rol protector contra enfermedades como neumonía, meningitis, leucemia, diarrea, infecciones del oído y asma, además contribuye a la prevención del sobrepeso al proporcionar los requerimientos energéticos adecuados y fomentar el vínculo afectivo materno-filial. En cuanto a la madre, la LM se asocia con una reducción del riesgo de desarrollar cáncer de ovario y mama, diabetes y osteoporosis. Investigaciones recientes de la Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna (APILAM) (4) sugieren un beneficio adicional a largo plazo: la posible disminución de casos de artritis reumatoide.

Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) (5), la lactancia materna exclusiva (LME) es el primer y único alimento que los recién nacidos y lactantes deben recibir durante los primeros seis meses de vida, sin implementar otro sólido o líquido, que no sea la leche materna, incluyendo el agua.

Según el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) (6), a nivel mundial, la tasa de LME presentó un incremento del 37,1% al 48% desde el 2012 al 2022. Por otro lado, se evidencia que en América Latina y el Caribe, la

LME se incrementó del 34,3% al 43,1%. En el Perú, en el período 2009-2023, la LME no ha presentado diferencia significativa, presentó incremento pasando del 68,5% al 69,3%; la meta nacional de LME para el 2030 es del 90%. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) (7) del 2023, a nivel nacional, la región con menor tasa de LME es Ica con 49%, el segundo lugar es Madre de Dios con 55% y seguido de Lima Provincias con 56%; Lima Metropolitana ocupa el cuarto lugar de regiones con menor tasa de LME con el 60%.

El observatorio del CEPLAN (6) propone que para alcanzar la meta nacional del 90% de LME en 2030, es crucial fortalecer las campañas educativas para reducir la desigualdad en el acceso a la información. Esta efectividad se evidencia en estudios como el de Masapanta y Alvear (8) en Ecuador, donde las estrategias educativas aumentaron significativamente el conocimiento (57.7% a 93%) y la técnica de LME (45.9% a 90.9%) en madres primerizas. Similarmente, Angulo y Salazar (9) en Perú, demostraron la eficacia de las intervenciones educativas en gestantes y púerperas, elevando el conocimiento (32.6% a 85.6%) y la práctica de LM (76.5% a 99.2%).

La política peruana promueve la LME a través de normativas, por ejemplo, la Norma Técnica N° 105 (10) para la atención de gestantes adolescentes, y la “Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna, 2017” (11) junto al “Reglamento de Alimentación Infantil” (12), que capacitan al personal de salud para una consejería efectiva.

Acorde al Reglamento de Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna-2024 (13) y la Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño sano (CRED) (14), Enfermería es responsable y participante activo en la promoción, seguimiento y apoyo de la LM en el ámbito hospitalario y comunitario, respectivamente. Las estrategias de Enfermería para lograr una LME exitosa y la continuidad prolongada de LM son las sesiones educativas mediante consejerías y charlas educativas.

En el centro de salud Mirones, ubicado en Cercado de Lima Metropolitana, se realizó una entrevista al personal encargado del servicio de CRED respecto al nivel de conocimientos y prácticas sobre LME en madres primíparas, refieren que presentan brechas de conocimientos y dificultades en la práctica. Posterior a ello, se realizó entrevistas a las madres para corroborar la información, algunas respuestas fueron “¿Le puedo dar agua?” “Y si no le doy LM, ¿qué pasa?”; al observar la mamada, se evidencia que algunas madres presentan grietas en los pezones y dolor. Ante la evidencia, se refleja la necesidad de reforzar la información sobre la LME.

Lo mencionado genera una serie de interrogantes cómo ¿Es viable modificar conocimientos y prácticas de las madres sobre lactancia materna exclusiva?, ¿Es posible mejorar los conocimientos al aplicar un programa de consejería sobre lactancia materna exitosa?, ¿Es posible mejorar las prácticas de la lactancia materna al aplicar un programa de consejería sobre lactancia materna exclusiva?

Esta problemática, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad del programa de consejería “Lactancia de amor” en los conocimientos y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones en el año 2025?

1.2. Objetivos

OBJETIVO GENERAL

Determinar la efectividad del programa de consejería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de ejecutar el programa Lactancia de amor.
- Identificar las prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de ejecutar el programa Lactancia de amor.

1.3. Justificación de la investigación

La LME es la intervención más eficaz para asegurar el crecimiento, desarrollo y supervivencia de cada niño según la OMS y UNICEF. Constituyéndose en un pilar fundamental para la reducción de la mortalidad y morbilidad infantil a nivel internacional y nacional; beneficioso para el bienestar materno, el vínculo materno-niño y reducción de costos en la familia, hambre cero y favorecer la salud, concordante con los ODS número 2 y 3.

Si bien el Perú está encaminado con 69,3% en el 2023 para lograr la meta nacional para una LME exitosa en al menos el 90% de lactantes mediante las estrategias educativas y campañas promotoras de LM. Aún existen brechas de conocimientos sobre la importancia de la LME principalmente en madres primerizas por lo que la enfermera es pieza fundamental como fuente de conocimientos y recursos en el proceso de la LM.

Las madres primerizas es la población que está más expuesta a la desinformación por la falta de experiencia, desinformación, exposición de mitos, inseguridad personal y falta de soporte familiar y profesional adecuado; todos estas barreras se pueden evitar mediante una adecuada consejería donde se le brinde información verídica sobre la LM y herramientas acorde a las necesidades que presenten; uno de los agentes de cambio en pro de la LM es la enfermera como agente educador y soporte de primera línea desde la primera hora de vida del lactante y en todas las etapas del desarrollo en los primeros años de vida.

1.4. Limitaciones del estudio

Las limitaciones que se podrían presentar es que los resultados solo se podrán generalizar a poblaciones similares y que lleven el programa.

CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

2.1. Marco teórico

2.1.1. ANTECEDENTES

- Antecedentes Internacionales

Charu, S., et al. (15), en el año 2024 en el país de India, desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar la efectividad de una intervención educativa sobre lactancia materna en los conocimientos y prácticas de las madres. Es un estudio de tipo cuantitativo, diseño pre-post test y se aplicó un cuestionario y la escala LATCH en una población de 54 madres puérperas. Los autores concluyeron que la intervención fue efectiva por el incremento significativo de los conocimientos y prácticas de las madres.

Masapanta, J., Alvear, M. (8), en el año 2023 en el país de Ecuador, elaboraron un estudio con el objetivo de elevar el nivel de conocimiento y promoción de la lactancia materna en madres primerizas a través de estrategias educativas. El tipo de estudio fue cuantitativo, de diseño cuasi experimental, se aplicó un cuestionario pre-post test en 45 madres primerizas que se encuentran en período de lactancia. El estudio concluye que:

“Las estrategias educativas para la promoción de lactancia materna aplicadas en el presente estudio resultaron efectivas, porque las madres pasaron de un nivel regular de conocimientos a uno bueno, lo que es significativo y beneficioso para la alimentación eficaz del recién nacido.”

Abdulahi, M. (16), et al, en el año 2021 en el país de Etiopía, realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la efectividad de la intervención educativa sobre lactancia materna. El estudio de tipo cuantitativo, de diseño pre experimental debido a que hace el estudio con dos grupos de madres siendo uno de grupo control con 219 madres y otro de grupo de estudio con 249, siendo un total de 468 de madres en el estudio. Se usó diversas herramientas para la recolección de datos, uno de ellos es un cuestionario de lactancia en la versión Afan Oromo (AO), se usó la Escala de Actitud Alimentaria Infantil (IIFAS) y se realizó la toma de medidas antropométricas de peso y talla a los lactantes de ambos grupos. El estudio concluye que la efectividad de las intervenciones educativas fue significativa y exitosa principalmente en las prácticas y

exclusividad de la LM; no hubo diferencia significativa en los conocimientos pero sí se puede apreciar el incremento de conocimiento en las madres de estudio.

López-García, E. (17), en el año 2020 en el país de España, realizó un estudio con el objetivo de conocer la efectividad entre la educación sanitaria sobre la lactancia materna en mujeres embarazadas en últimas semanas de fecha de parto relacionado a su decisión de amamantar. Fue un estudio de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental, se aplicó cuestionario como herramienta de recolección antes y después de la educación sanitaria en 102 mujeres embarazadas. Las conclusiones del estudio dicen:

“En la actualidad existe evidencia científica de un notable descenso de madres que amamantan a sus hijos debido a una carencia de información adecuada sobre el tema. Para ello, se hace necesaria la realización de educación sanitaria, los programas de educación tienen un afán promotor en el uso de la lactancia natural.”

Prihanti. G, et al. (18), en el año 2020 en el país de Indonesia, desarrolló un estudio con el objetivo de determinar la efectividad de la capacitación en lactancia materna para aumentar los conocimientos, actitudes y prácticas en los grupos de apoyo del Programa de Salud Pública Pesantren II en el Centro de Kediri, estos grupos brindan apoyo a las embarazadas y madres que tienen lactantes menores de 2 años en educar y orientar sobre la LM y mejorar la práctica de la misma. Fue un estudio de tipo cuantitativa, de diseño cuasiexperimental, se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de información, en una muestra de 60 personas de los grupos de apoyo. Al finalizar, se concluye que la capacitación en asesoramiento sobre lactancia materna es eficaz para aumentar los conocimientos, actitudes y prácticas en los grupos de apoyo a la lactancia materna.

- Antecedentes Nacionales

Chafalote, A., Ramos, W. (19), en el año 2023 en la ciudad de Lima, realizaron un estudio con el objetivo de determinar la efectividad de la intervención educativa

en el conocimiento y práctica de la LM en puérperas, Hospital Regional de Huacho-2023. El estudio que realizaron fue de tipo cuantitativo, de diseño pre experimental y se utilizó como instrumentos un cuestionario y una ficha de observación sistematizada. La conclusión del estudio es que la intervención educativa fue significativa con relación al aumento del conocimiento y la mejora de la práctica de la LM en puérperas del hospital.

Angulo N., Salazar A. (9), en el año 2022 en la ciudad de Arequipa, realizaron un estudio con el objetivo de determinar la efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimiento y la práctica sobre lactancia materna en gestantes y puérperas. Fue un tipo de estudio cuantitativo, de diseño cuasi experimental, el instrumento utilizado fueron los cuestionarios pre y post test en 132 pacientes gestantes y puérperas. El estudio concluye que:

Se concluyó que la intervención educativa fue efectiva; las gestantes y puérperas que asisten al área de Hospitalización de Gineco-Obstetricia del Hospital III Goyeneche incrementaron el nivel de conocimiento del 32.6% al 85.6% y en la práctica del 76.5% al 99.2% sobre lactancia materna después de realizar la intervención educativa “Lactancia Materna, un regalo para toda la vida”.

Ramos, W. (20), en el año 2022 en la ciudad de Puno, desarrolló un estudio con el objetivo de determinar la efectividad de las estrategias preventivo promocionales en el conocimiento y práctica de la lactancia materna en puérperas/gestantes del Centro de Salud Jorge Chávez. El estudio fue de tipo cuantitativo y cuasi experimental, el instrumento utilizado fue el cuestionario en dos grupos (control y experimental) con 21 participantes cada uno. La conclusión del estudio dice que la intervención con actividades preventivo promocionales fueron efectivas en el conocimiento y práctica en las madres que participaron en el estudio.

Aguirre P., Changana I. (21), en el año 2021 en la ciudad de Huaura, realizaron un estudio con el objetivo de determinar el efecto de una intervención educativa en el nivel de conocimiento y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses en Carquín. Fue un estudio de enfoque cuantitativo y

de diseño cuasi experimental, utilizando un cuestionario pre y post test de 25 preguntas para determinar el nivel de conocimiento y una guía de observación con 18 ítems para determinar la práctica de lactancia materna en 30 madres con niños menores de 6 meses. Las conclusiones del estudio mencionan que la intervención educativa tuvo un efecto significativo al mejorar el nivel de conocimiento y práctica de las madres con lactantes menores sobre lactancia materna exclusiva.

Aguilar, B. (22), en el año 2020 en la ciudad de Lima, realizó un estudio con el objetivo de determinar la efectividad de la intervención educativa para el éxito de la lactancia materna en los conocimientos y práctica de las puérperas adolescentes del hospital E. Bernal. Fue de tipo cuantitativo y de diseño pre experimental, la herramienta de recolección fue el cuestionario aplicado en 20 puérperas adolescentes. El estudio concluye que se afirma que la intervención educativa tuvo éxito en la lactancia materna alcanzando un buen nivel de efectividad.

2.1.2. REFERENTE TEÓRICO

- Aspectos teóricos conceptuales sobre LM
 - Definición

La LME es el tipo de alimentación que recibe el bebé solo con leche materna durante los primeros 6 meses de vida, no se debe de brindar otro alimento sólido o líquido, tampoco se debe de dar agua; excepto vitaminas, minerales, soluciones rehidratantes o medicamentos cuando sea necesario y recomendado por un médico. (3)
 - La lactancia materna exclusiva en el mundo y el Perú

Según la OMS, en la última década se ha visto un notable aumento de que los lactantes menores de 6 meses reciban exclusivamente lactancia materna de más de un 10% en todo el mundo, ello significa que hasta el 2024, el 48% del total de niños lactantes reciben leche materna a nivel

mundial. Se está cerca de la meta mundial que salvará la vida de más de 820 mil niños y niñas por año; sin embargo, no se logrará la meta si es que no se erradica las dificultades que aún existen dentro de la brecha para el bienestar de los niños desde sus primeros meses de vida. La brecha existente aún es de aproximadamente de 4.500 millones de persona no gozan de los servicios de salud, en esta población se encuentran las madres que no reciben el apoyo mediante las consejerías que necesitan para lactar de manera óptima a sus bebés. (23)

Mientras en el Perú, se ha visto una significativa diferencia de los niños que nacen en las áreas rurales y urbanas, los niños que nacen en las áreas rurales (76.7%) son los que tienen un mayor porcentaje de recibir lactancia materna exclusiva que los de área urbana (61.4%), estos tienen un mayor porcentaje de recibir Fórmulas Comerciales Infantiles. Esta problemática, comienza desde la primera hora de vida de los recién nacidos, debido a que uno de cada dos peruanos nacidos son colocados en el pecho de su madre, exactamente, el 53.4% de recién nacidos no reciben lactancia materna en el primer momento, aumentando el riesgo de abandono a la lactancia materna. En los primeros 6 meses, solo el 65.9% de niños y niñas reciben sólo leche materna. (24)

- Composición de la leche materna

- Agua: siendo el 88 a 90% de la leche y relacionada con la hidratación del bebé.
- Carbohidratos: 7.3 g/100 ml de leche. La azúcar principal es la lactosa, sin embargo, se han evidenciado más de 50 oligosacáridos que son el 1.2% de la leche como la galactosa, glucosa, etc.
- Lípidos: está en un intervalo de 3 a 4 g/100 ml de la leche. Brinda desde el 30 al 55% de kilocalorías, siendo el más característico los triglicéridos, también se presentan los fosfolípidos y colesterol.

- Proteínas: se encuentra de 1g/100 ml, constituyendo el 0.9% de la leche y presentándose en mayor cantidad la caseína (40% de todas las proteínas presentes).
 - Inmunoglobulinas: se presentan IgA, IgG, IgM, se destaca la IgA por la protección que brinda hacia las mucosas del recién nacido siendo más notorio por sus altas concentraciones en la leche de tipo calostro.
 - Vitaminas: se evidencian todas las vitaminas en la leche materna; sin embargo, la vitamina K se encuentra en dosis bajas, por tal motivo, al nacer se debe de aplicar una inyección de vitamina K de 1 mg intramuscular.
 - Minerales y elementos traza: los minerales se encuentran completos y en cantidades adecuadas para las necesidades del lactante.
 - Hierro: se encuentra hierro en la leche materna, pero en cantidades bajas.
 - Zinc: la absorción del zinc en la leche materna es mayor a comparación de las fórmulas lácteas artificiales y leche de vaca; sin embargo, sigue siendo un factor influyente en el inadecuado desarrollo por deficiencia de zinc.
 - Selenio: se encuentra en mayor cantidad en la leche materna que en la leche de vaca.
 - Flúor: la absorción del flúor en la lactancia materna es mayor que cuando se consume leche de vaca, a pesar de tener menor concentración de flúor. Se evidencia que los lactantes alimentados con leche materna presentan menos caries y menores problemas bucales.
 - Calcio/Fósforo: Se favorece la absorción de calcio debido a que, en la leche materna, la relación de calcio/fósforo es de 2 a 1. (25)
- Importancia
- Los estudios actuales afirman que la lactancia materna es el método de alimentación infantil más saludable y seguro que brinda beneficios a corto y largo plazo a los niños. Se benefician tanto en el estado nutricional, de

salud, afectivo y desarrollo; además, la madre, familia y comunidad reciben beneficios de la lactancia materna. Por estos motivos la lactancia materna es considerada como un derecho fundamental. (26)

- Beneficios para el bebé
 - Requerimientos nutricionales adecuados y suficientes
 - Apoyo en el desarrollo y crecimiento tanto físico como mental y emocional, en especial a la vista a los bebés prematuros
 - Genera un mayor coeficiente intelectual
 - Presenta anticuerpos protectores contra enfermedades como asma, alergias, diarrea e infecciones respiratorias
 - Se reduce el riesgo de que padezca el síndrome de muerte súbita del lactante, obesidad, anemia, diabetes, leucemia, cáncer infantil, colesterol alto e hipertensión
 - Mejor formación dental
 - Favorece al adecuado desarrollo del habla
 - Mayor facilidad en digerir y así, menor prevalencia de gases y estreñimiento
 - Se fortalece el vínculo madre-hijo (10,27)
- Beneficios para la madre
 - Disminución de la hemorragia postparto
 - Disminución de la depresión post parto
 - Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de ovario y mama, diabetes tipo 2, hipertensión, ataques cardíacos, osteoporosis, osteopenia, fractura de cadera y anemia
 - Recupera su peso más rápido y disminuye el riesgo de obesidad
 - Contribuye a la seguridad de la madre y confianza
 - No tiene costo en la preparación y aplicación (10,27)
- Consecuencias de no brindar LM

Los lactantes sin LM presentan un incremento del 80% de padecer diarrea.
Presentan casi quince veces más mortalidad por neumonía.

Presentan mayor riesgo de asma y sibilancias desde tres a más veces a partir del año de edad.

Presentan un 33% más de riesgo de padecer Diabetes Mellitus dentro de sus primeros 20 años de vida.

El uso de mamaderas puede interferir en la maduración de funciones orales como ejemplo se tiene mayor riesgo de deglución atípica, de respiración bucal a lo que conlleva una ventilación inadecuada, de caries en niños, de disfunción masticatoria, de alteración en el desarrollo máxilo-facial, de dificultades en la fonoarticulación y de alteración en la postura corporal.

Presentan mayor riesgo de alteración de la microbiota intestinal

Presentan mayor riesgo de episodios de apnea, desaturación de oxígeno y bradicardia. (28)

- Tipos de lactancia

Lactancia materna: alimentación por leche

Lactancia materna exclusiva: se brinda solo leche materna sin ningún otro tipo de sólido o líquido

Lactancia materna predominante: lactancia materna, incluye a alguna nodriza como fuente principal

Lactancia de biberón: brindar leche ya sea natural como de fórmula por tetina

Lactancia de múltiples: lactancia de dos a más hijos con leche de madre

Lactancia diferida: lactancia que se le brinda de leche materna extraída

Lactancia directa: lactancia directamente del pecho de la madre

Lactancia mercenaria: lactancia por leche materna diferente a la progenitora mediante el cambio de alguna remuneración

Lactancia mixta: se refiere a la lactancia materna junto a la alimentación complementaria

Lactancia solidaria: lactancia por leche materna diferente a la progenitora sin el cambio de alguna remuneración

Relactancia: retorno a la lactancia materna exclusiva después de alimentación complementaria o la suspensión de la lactancia. (29)

- Tipos de leche

Pre-calostro: está acumulado en la zona alveolar en el tercer trimestre del embarazo

Calostro: es producido durante los primeros 4 días después del nacimiento siendo escaso en cantidad, pero denso en consistencia. Es considerado como la primera “vacuna” del bebé porque presenta mayores sustancias inmunológicas, contiene un efecto laxante para la eliminación del meconio, disminuye la presencia de la ictericia del recién nacido.

Leche de transición: es producida entre el 4 a 15 días luego del parto, incrementado la cantidad y el volumen de la leche

Leche madura: se evidencia durante los primeros 6 meses posparto teniendo un aproximado de 700 a 900 ml/día

Leche de pretérmino o leche de prematuro: se encuentra en mujeres con partos prematuros, esta leche presenta mayor cantidad de grasas, sodio, calorías, la lactoferrina e IgA, pero menor concentración de lactosa, calcio fósforo y ocasionalmente de proteína en recién nacidos con un peso menor de 1.5 kg. (30)

- Técnica de amamantamiento

Iniciar con la comodidad de la madre y su hijo en una posición que sea placentera para ambos, ya sea que la madre esté recostada o sentada. Al estar sentada, la columna de la madre debe de estar recta, rodillas ligeramente elevadas, colocar al bebé en la curva de su codo y en lo posible sostener las nalgas, oreja, hombro y cadera la bebé en una línea recta.

Explicar a la madre que puede sostener la mama con los dedos a 3-4 cm detrás del pezón en forma de “C” (en caso de mamas pequeñas en forma de “L”) y acercar al bebé al pecho.

La nariz del bebé debe de estar frente al pezón que debe de rozar. Rozar el labio superior del bebe para la estimulación

Esperar que el bebé abra bien la boca, debe de agarrar una buena parte del pecho hasta la areola.

En el amamantamiento, explique a la madre que la lactancia es a demanda, de día y de noche (en promedio de 24 horas, 8 a 12 veces) y el tiempo de lactancia es variado en cada bebé. (10,27)

- Consecuencias de una inadecuada técnica de amamantamiento

Dolor

Grietas en el pezón

Ingurgitación

Obstrucción de conducto lácteo

Mastitis

Absceso mamario

Estrés (31)

- Posiciones de LM

Recordar que en todas las posiciones de lactancia se deben de considerar la correcta técnica en cualquier posición que realice la madre.

Posición natural o biológica: la mamá debe de estar recostada y el bebé echado en decúbito ventral sobre ella.

Posición de cuna o clásica: la mamá debe de estar sentada con la espalda apoyada en el respaldo del asiento, sostener al bebé sobre el antebrazo del mismo lado de la mama del que va a lactar, y la mano opuesta sostiene la mama que va a dar a lactar. El brazo inferior del bebé debe abrazar la

cintura de la madre y la barriga del bebé debe de estar en frente y tocando la barriga de la madre.

Posición acostada: ayudar a descansar mientras amamanta. Ambos, bebé y madre, deben de estar acostados, uno frente al otro o el bebé también puede estar encima de la mamá. Se puede hacer el uso de la almohada para que la madre pueda sostener al bebé. Educar a la madre en esta posición es importante para evitar ahogamientos del bebé.

Posición sandía o por debajo del brazo: se usa también luego de una cesárea, en caso de mellizos o gemelos, cuando la madre tiene conductos lácteos bloqueados o hay una dificultad en el agarre. La madre debe de estar sentada con ayuda de una frazada o almohada en cada lado. Los pies del bebé o los bebés deben de estar atrás del brazo o brazos de la mamá.

Posición con el ala opuesto: se usa cuando el bebé es muy pequeño o en bebé enfermo. La madre debe de estar sentada en una silla o mueble con respaldar, el bebé debe de estar echado en decúbito dorsal y los pies del bebé deben de pasar por debajo del brazo opuesto que la madre usa para lactar mientras la mano de la madre debe de sostener la cabeza del bebé.

Posición de caballito: se usa cuando el bebé es hipo/hipertónicos, con fisura palatina o la madre tiene mamas muy grandes. La madre debe de estar sentada en una silla o mueble con respaldar, el bebé debe de estar echado decúbito dorsal con el apoyo de una almohada entre la pierna de la madre y la espalda del bebé se acercará al pecho, los pies del bebé deben de pasar por debajo del brazo del pecho a mamar mientras que la mano de la madre sostiene la cabeza de su bebé. (10,27)

- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal

En los controles prenatales, se evalúa el crecimiento del feto y se vigila la salud intrauterina.

Se brinda recomendaciones para la disminución de molestias propias del embarazo.

Se prepara para el parto.

Se brinda información sobre el cuidado del recién nacido y lactante.

Se brinda información a la gestante, familia, pareja y/o persona de confianza de la madre sobre las ventajas y beneficios de la lactancia materna; peligros y desventajas de los sucedáneos de la leche materna (fórmulas lácteas, leche de vaca, leches artificiales, entre otros).

Se brinda información sobre la importancia del cuidado canguro, contacto piel a piel y alojamiento conjunto.

Se brinda información sobre las técnicas de lactancia materna para un proceso exitoso y eficaz. (27)

- Lactancia materna en el hogar

A la llegada del bebé al hogar, puede generar estrés en el ambiente familiar al ser una experiencia nueva y pueden surgir interrogantes sobre la lactancia materna. Si estas interrogantes no son resueltas con información verídica y comprensible, se puede llegar al abandono de la lactancia materna en el hogar. Desde esta problemática, se resalta la importancia del papel del profesional capacitado en consejería de lactancia materna para la educación y concientización a la madres y familia en este proceso. (32)

- Aspectos teóricos conceptuales del conocimiento sobre LM

- Definición de conocimiento

Según Juan Segundo (2023), en la Enciclopedia Concepto de la Editorial Etecé, los conocimientos son el resultado obtenido en el proceso gradual y progresivo de aprehensión del mundo sobre personas, objetos, ideas, entre otros. (33)

- Importancia del conocimiento

Según Euroinnova, la importancia de los conocimientos radica en la base del desarrollo y evolución de la cultura dentro de la sociedad, debido a que el conocimiento guía los pensamientos, ideas y comportamientos para la toma de decisiones. (34)

- Conocimiento sobre LM

Según Eufemia Altamirano (2022) (35), todo concepto tanto en definición, procedimiento y hechos relacionados a la LM que adquiere la madre de manera subjetiva y personal, estos conocimientos serán influenciados en las experiencias e interacción con su entorno.

El entorno en donde se desarrolla la madre con el lactante puede influenciar tanto positiva o negativamente la LM, según el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría (36), la familia, el profesional de salud y la sociedad repercute en la información que adquiera la madre, esta puede llegar a ser verídica o generar mitos que perjudique una LM exitosa.

- Aspectos teóricos conceptuales de la práctica sobre LM

- Definición de práctica

Según Julián Pérez y Ana Gardey (2021) (37), la práctica es toda aquella acción en la que se desarrolla a raíz de la aplicación de conocimientos previos.

- Importancia de la práctica

Según Elisa Montes (2021) (38), la importancia de la práctica dentro de un aprendizaje efectivo se da en la repetición de la acción en la que se aplican los conocimientos previos mediante la repetición. A medida que se replique más veces la acción que se requiere, el cerebro lo irá asociando a una “segunda naturaleza”.

- Práctica de LM

Según la OMS y UNICEF (39), las prácticas de LME se basan en los comportamientos, decisiones y acciones que realiza la madre para alimentar a su bebé solo con leche materna de manera exclusiva. Estos se basan en la exclusividad, frecuencia, técnica, la libre demanda y duración de la lactancia que le brinda la madre a su bebé.

Aspectos teóricos conceptuales de la consejería en LM

- Definición de la consejería en LM

Según la Guía Técnica para la consejería en LM (10), la consejería en LM es aquel proceso educativo y comunicacional que es realizado por el personal de salud que esté capacitado en LM y consejería, este brinda apoyo oportuno acorde a sus necesidades e información verídica a la gestante, puérpera y/o madre relacionado a la lactancia de la misma, todo este proceso tiene el objetivo de que la madre logre tomar decisiones autónomas e informadas para el amamantamiento de su bebé.

- Importancia de la consejería en LM

Según el dr. Jose Leon (40), la importancia de la consejería en LM radica en lo valioso que es como recurso para las madres que deseen amamantar a sus hijos y orientar a las que no desean por falta de información adecuada sobre la LM.

La consejería en LM permite alcanzar una LM exitosa y por consiguiente, mejores resultados en la nutrición y salud de los niños, así como la disminución de la mortalidad infantil; además, las madres se empoderan en la crianza de sus hijos y mejoran su salud mediante la prevención de enfermedades como el cáncer de útero, mama y entre otros.

- Metodología de la consejería en LM

Según la Guía Técnica de LM (10), la consejería en LM considera que las habilidades que todo personal de salud debe de tener son las habilidades de comunicación para escuchar a la madre, generarle confianza y seguridad en sí misma; el respeto hacia sus creencias, cultura y pensamientos sin decirle lo que debería o no debería hacer sin presiones a realizar alguna acción en específico; ejecutando estas habilidades, la madre logrará una lactancia exitosa.

Además, al realizar la consejería se debe de considerar los cinco momentos de manera secuencial, se tiene que desarrollar en el establecimiento de salud u hogar.

Momento 1: Inicio de la consejería

Se comienza con la presentación a la madre con el nombre, la ocupación y solicitar a la madre el nombre de ella y el de su bebé, de ser el caso.

En esta etapa, es importante ser amable y respetuoso con la madre para poder generar comodidad. Tener cuidado con la postura, actitud de escucha y gestos, evitar las barreras que puedan interferir en la comunicación por ejemplo, el teléfono, escritorio, tablero, etc. Demostrar interés en la conversación para que la madre pueda sentir confianza de hablar de sus necesidades en la LM.

Momento 2: Búsqueda de los factores causales o de riesgos

El momento 2 se caracteriza en el análisis de las dificultades que pueda tener la madre en la preparación, inicio o continuidad de la lactancia materna; y ayudar a encontrar las causas.

Se hace uso de las habilidades de comunicación para escuchar y comunicarse con la madre.

Se hace uso de la historia clínica de lactancia según la Guía Técnica de Lactancia Materna y la Ficha de observación de la mamada para la recolección de la información.

Momento 3: Reforzar la confianza y dar apoyo

Es el momento de la búsqueda de alternativas de solución según las causas identificadas en las dificultades y necesidades de la madre en la LM. Se continua con el uso de las habilidades para mantener el apoyo y reforzar la confianza de la madre. En caso que se cuente con la pareja, familiar o persona de confianza de la madre en la consejería de LM; el personal de salud debe de incentivar y fomentar la participación activa para que puedan apoyar a la madre en su decisión.

Momento 4: Registro de la consejería

Se hace el registro en la ficha clínica de LM y de las actividades producidas (Registro H1S o el que corresponda)

Momento 5: Cierre y seguimiento

En el último momento de la consejería, se realiza el cierre, en caso de ser necesaria, se coordina la próxima cita o visita y que se registra en el Carné de CRED la fecha acordada o en el documento correspondiente.

Es importante una despedida cálida y afectuosa para mantener un vínculo positivo, esto ayudará a motivar a la madre, pareja, familiar o la persona de confianza de regresar al establecimiento de salud o recibir la siguiente visita domiciliaria.

Rol de la Enfermería en la LM

La Enfermería se caracteriza por sus cuatro roles fundamentales que son de investigación, administración, asistencial y docencia (41). Este último es el que se presenta cuando la enfermera realiza la consejería sobre LM a las madres acorde a las necesidades y dificultades que puedan presentar. Estos conocimientos las empoderan y les brindan confianza y seguridad en la lactancia que le brindan a sus bebés; posterior a ello, les ayuda a fortalecer el vínculo afectivo madre-hijo y que el bebé pueda tener un adecuado crecimiento y desarrollo en sus primeros años de vida. (42)

La enfermería no solo educa sino también brinda acompañamiento y apoyo a la madre, padre, familiar y/o persona de confianza de la madre en el proceso de la

LM. El ambiente de confianza que se genera permite acercar más a la madre y su entorno a la enfermera para poder resolver sus dudas y dificultades que puedan tener durante la LM no solo en el momento de la consejería sino, también después de la misma. (42)

Teóricas de Enfermería sobre la consejería y LM

Marco conceptual de las prácticas de lactancia materna de Dorothy E. Smith

Plantea que la práctica de lactancia materna que experimentan las mujeres son experiencias subjetivas en el que se tiene que reconocer las emociones, satisfacciones y desafíos que presenten al momento de amamantar. Todas estas experiencias subjetivas son influenciadas por el entorno e instituciones sociales (trabajo, familia y salud) en desarrollar la LM de manera satisfactoria o no. Por lo que es importante empoderar a las mujeres en la toma de decisiones en beneficio a su salud y la de su bebé con la información adecuada y las oportunidades justas. (43) El profesional de Enfermería es parte fundamental del entorno de la madre, familia y/o acompañante para empoderar con el apoyo e información para facilitar la toma de decisiones durante el proceso de la LM.

- Modelo de promoción de la salud de Nola Pender

Refiere en servir a la identificación de conceptos relevantes sobre las conductas que tienen el objetivo de promocionar la salud y la integración de los hallazgos de la investigación mediante la educación a la salud al paciente, familia y comunidad. (44) Uno de los roles de la Enfermería es el rol educativo y es crítico para lograr una LM exitosa debido a que se le brinda los conocimientos y herramientas necesarias a la madre, familia y/o acompañante.

- Adaptación del rol materno de Ramona Mercer

Resalta la importancia de que los profesionales de enfermería deben de tomar en cuenta el entorno tanto familiar, trabajo, entre otras entidades que rodean a la madre; debido a que estos influyen en la adopción del rol materno. Mientras la madre se sienta más vinculada a su hijo, también sentirá una mayor realización de los cuidados maternos, por lo que experimentará gratificación, placer y confianza que la guiará a la identidad maternal. (45) La LM es considerada como uno de los principales actos de amor materno y la enfermería es partícipe activo en la adaptación del rol materno debido a que influye en su toma de decisiones a la madre, familia y/o acompañante brindándole seguridad y herramientas para lograr una LM exitosa.

- Teoría de los Cuidados de Kristen Swanson

Kristen Swanson propone en su Teoría de los Cuidados que los cuidados se conciben como una forma educativa para relacionarse con el usuario con compromiso y responsabilidad personal. La teoría propone cinco procesos básicos: conocimientos, mantener creencias, hacer por, estar con y posibilitar. Los cinco procesos básicos relacionados a la LM, conocimientos en el entendimiento del proceso de la LM, brindar la información acorde a sus necesidades para lograr una LM exitosa; mantener creencias para mantener la actitud de la madre en brindar a su bebé la LM; hacer por es velar por las necesidades de la madre durante la LM; estar con es en base al apoyo del profesional de Enfermería que se le brinda a la madre, a la familia o acompañante al disipar dudas, temores y tranquilidad; y posibilitar es brindar alternativas y facilidades de solución ante cualquier problema que tenga la madre aliviando el sufrimiento y fortaleciendo el proceso de la LM. (46)

- Teoría de las Relaciones Interpersonales de Hildegard Peplau

Hildegard Peplau propone en su teoría que la enfermera tiene la posibilidad de ayudar al usuario mediante una interacción interpersonal

para facilitar la resolución de problemas acorde a sus necesidades. El rol de la enfermera en esta teoría es de educadora, consejera y fuente de recursos. La relación Enfermera - usuario que se consolida consta en cuatro fases que son identificación, explotación, orientación y resolución del problema. (47) Aplicando la teoría a la consejería sobre LM, la consejería realza el rol de educadora de la Enfermería para poder brindar de conocimientos y herramientas en el proceso de la LM siendo este una etapa diferente como madre.

2.2. Formulación de hipótesis

Hipótesis de investigación:

H_1 : El programa de consejería “Lactancia de amor” es efectivo en los conocimientos y prácticas sobre LME en madres primíparas del Centro de Salud Mirones

Conocimiento Antes $\neq$ Conocimiento después

Práctica Antes $\neq$ Práctica después

Hipótesis nula H_0 :

El programa de consejería “Lactancia de amor” no es efectivo en los conocimientos y prácticas de las madres sobre LME en madres primíparas del Centro de Salud Mirones

Conocimiento Antes = Conocimiento después

Práctica Antes = Práctica después

2.3. Metodología

2.3.1. Tipo, método y diseño de la investigación

Según Hernández Sampieri (48), el estudio es de tipo explicativo debido a que estas investigaciones van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, explica el porqué y cómo; está dirigido a responder a la hipótesis ya planteada con anterioridad. Además, es cuasi experimental, por ser no aleatorizados y que la población ya estaba formada antes de iniciado el estudio y pues en situaciones sociales donde se carece de control experimental debido a que en el estudio no se le puede negar a un grupo de madres que cumplen con los criterios de inclusión una consejería que se considera beneficiosa. Es de corte transversal debido a que se realizará la medición de los resultados antes y después del programa una sola vez.

Según Hernández, Fernández y Baptista (49), basándose en las obras de Auguste Comte y Émile Durkheim, el estudio es cuantitativo debido a que se basan que el conocimiento es objetivo a partir de un proceso deductivo mediante la medición numérica y análisis estadístico inferencial; se prueba las hipótesis que fueron formuladas.

2.3.2. Población

La población estará conformada por 30 madres.

2.3.3. Tamaño de muestra

El tamaño muestral estará conformado por la totalidad de la población.

2.3.4. Selección de muestra

- Criterios de inclusión:
 - Ser madre primípara,
 - Cuyo hijo sea atendido en los servicios de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud Mirones,
 - Que acepten participar de manera voluntaria en la investigación.
- Criterios de exclusión:
 - Analfabetas,
 - Discapacidad intelectual y física de miembros superiores,

- Que no se encuentre en la fecha de la aplicación del instrumento

2.3.5. Variables

Variable independiente: Programa de consejería sobre LME

Variables dependientes: Conocimientos sobre LME y Prácticas de LME

Variables intervinientes: Edad, grado de instrucción

2.3.6. Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual de variable	Indicadores	Valor final de la variable	Definición operacional de la variable
Conocimientos sobre LME	Según Ramos, W., (2022), los conocimientos son todos los conceptos y representaciones mentales que posee una o un conjunto de personas, adquiridos de manera gradual y que le permite la comprensión del mundo, sus objetos, fenómenos y hechos. La adquisición de ellos es un proceso desarrollado por el hombre para alcanzar a ser un ser racional diferenciándose de los demás seres vivos.	· Aspectos generales · Beneficios para el bebé · Beneficios para la madre · Tipos de leche · Técnica de lactancia · Posiciones de lactancia	Nivel: Conoce Mucho (13-18) Conoce Poco (7-12) No Conoce (0-6)	Representaciones mentales, constituida los conceptos y toda información que tienen las madres primerizas acerca de la Lactancia Materna Exclusiva. Será medido mediante un cuestionario aplicado mediante entrevista estructurada presencial y valorado en conoce mucho, conoce poco o no conoce.
Variable	Definición conceptual de variable	Indicadores	Valor final de la variable	Definición operacional de la variable
Prácticas de LME	Según Ramos, W., (2022), las prácticas son todos los procesos sociales desplegados en la cotidianidad y que permiten transformar y preservar las tradiciones, cultura y vida social. Estos	· Disposición o ánimo de la madre · Disposición o ánimo de la o del bebé · Apariencia de los pechos · Posición de la	Tipo: Práctica Adecuada	Es la manera que la madre adopta de manera cotidiana para alimentar a su bebé mediante la lactancia materna. Esta práctica estará categorizada en práctica adecuada o práctica

	procesos sociales se expresan en la forma de hacer las cosas y se basan en los conocimientos que poseen las personas sobre determinados sucesos, objetos, fenómenos, etc.	madre · Posición de la o del bebé · Agarre del pezón por la o del bebé · Succión de la o del bebé	Práctica Inadecuada	inadecuada, a partir de las observaciones realizadas en las sesiones del programa.
--	---	--	---------------------	--

2.3.7. Técnicas e instrumentos

Se utilizará la técnica de entrevista estructurada presencial y como instrumento para esta técnica se tiene el cuestionario “Cuestionario para madres primíparas del Centro de Salud Mirones, 2025”, en el cual se encuentran 18 ítems tipo Likert y se evaluará el nivel de conocimiento sobre LME en conoce mucho (12-18), poco (6-11) y nada (0-5). El cuestionario fue validado por el Coeficiente de Validez de Contenido de Hernández-Nieto (2011) mediante 7 jueces expertos siendo 3 docentes expertas en Investigación y 4 licenciadas encargadas del área CRED de 4 centros de Salud de Lima Metropolitana. Obtuvo un CVC de 0.8790 que significa muy bueno.

Para aplicar el segundo instrumento, “Ficha de Observación de la Mamada” extraída de la Guía Técnica para la consejería en Lactancia Materna, se hará uso para evaluar si la mamada es adecuada o inadecuada, será inadecuada si se obtiene algún signo de una posible dificultad en la madre, bebé, pechos, posición, agarre y succión. La diferencia de jueces expertos entre el cuestionario y la ficha se debe a que el cuestionario fue validado en una prueba piloto con anterioridad, y la ficha se agregó a este proyecto de tesis actual. Obtuvo un CVC de 0.8927 que significa muy bueno

2.3.8. Plan de recolección, procesamiento y análisis de datos

Aprobado el proyecto de investigación por la instancia correspondiente, se solicita que la Dirección de la Escuela emita una solicitud hacia la Dirección de Redes Integrada de Salud de Lima Centro para la aprobación y autorización de la ejecución del estudio.

Recojo de datos:

Para la recolección de datos en el centro de salud de Mirones, se le presentará el formato de presentación del estudio a la directora del centro de salud de Mirones, Dra. Hildebrandt.

Posterior a la aprobación y permisos, se le solicitará al C.S. la información de los bebés menores de 6 meses al servicio CRED; y las historias clínicas (HC), al servicio de Archivo, para la recolección de datos personales como nombres de la madre e hijo, dirección y número de celular, serán almacenados y organizados mediante un Excel. Recolectada la información personal, se usará los números de celular para realizar llamadas telefónicas en primera instancia para contactar a las madres; en caso de no poder generar el primer contacto mediante llamada, se les escribirá mediante WhatsApp.

Primera fecha de recojo de datos para cada madre: será en el primer control de CRED a donde asista las madres con su niño RN o niño(a) menor de 6 meses.

-Aplicación del cuestionario: dura aproximadamente 15 minutos por madre, mediante entrevista estructurada presencial.

-Aplicación del formato de registro: se le pedirá a la madre que dé de lactar a su hijo para aplicar la ficha de la observación de la mamada.

- A cada grupo de madres identificadas y agrupadas de acuerdo con la fecha que asistan; se les realiza la consejería según cronograma del programa, considerando el grupo al que pertenecen, hasta terminar con las actividades programadas. (se coordina con la responsable CRED para las 4 citaciones que se les realice y las 2 visitas domiciliarias correspondientes).
- El programa está constituido por 5 sesiones (cada 15 días) según lo acordado con los directivos del C.S., siendo las 3 primeras en el mismo C.S. y las 2 últimas mediante visitas domiciliarias (2 por cada madre) con fines de consejería educativa en el hogar, abordando el tópico correspondiente del programa “Lactancia Amor”.

Segunda fecha de recojo de datos

Al término del cumplimiento del programa en las madres, se procederá a la segunda etapa de recojo de datos: Cuestionario (conocimiento) y Ficha de Observación de la Lactancia materna (práctica).

Procesamiento de datos: La información recolectada mediante el cuestionario y el formato de registro aplicado antes y después de la intervención será procesada en una matriz elaborada en el programa Excel, para su posterior representación en gráficos estadísticos y tablas, las mismas que permitirán la presentación de información y el análisis correspondiente.

Análisis de datos: En el análisis de datos, se aplicará previamente la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para la verificación de la distribución de los datos con el fin de elegir la prueba estadística a utilizar para la contrastación de la hipótesis. Posteriormente, se hará uso de la estadística inferencial, aplicando la prueba de rangos con Signo Wilconxon donde se verificará la aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación. Al aceptar la hipótesis de investigación, se concluye que el programa de consejería ha sido efectivo en los conocimientos y prácticas de las madres.

2.3.9. Consideraciones éticas. Consentimiento informado

Autonomía: Es aquella condición intransferible, individual e inquebrantable de cada ser humano de decidir en sus acciones sin influencia de presiones tanto internas como externas. Mediante el consentimiento informado se reconoce su autonomía de las madres en participar en la investigación de manera voluntaria.

Beneficencia: Este es un principio bioético que orienta a actuar en beneficio de la persona, familia y comunidad. La investigación fortalece la interacción enfermera y madre respetando la dignidad humana con actitudes empáticas y humanísticas, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos que este pueda presentar a la madre o el niño.

No maleficencia: Es aquel principio bioético que obliga a no causar lesión, daño o reducción de la fuerza vital de las demás personas, evitar toda aquella acción que implique algún perjuicio en la integridad humana.

Justicia: Es el principio moral que refiere de otorgar las mismas oportunidades de manera equitativa a cada quien le corresponda de manera honesta e imparcial. Todas las madres presentes que cumplan con los criterios de inclusión tienen la misma posibilidad de participar en el estudio y serán evaluadas de manera justa, objetiva, racional e imparcial en la investigación.

CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. Cronograma de trabajo

ACTIVIDADES	2025												2026		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Marz
Elaboración y planificación del proyecto de investigación															
Levantamiento de observaciones															
Presentación del estudio al comité universitario															
Presentación del estudio a las autoridades pertinentes (DIRIS y centro de salud Mirones)															
Ejecución del programa y recolección de datos															
Procesamiento de datos															
Elaboración del informe final															

3.2. Presupuesto

DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
Bienes			
Impresora + tinta de impresora	870.00	1	870.00
Paquete de hojas bond	15.00	2	30.00
Rotafolio A3 enmicado	60.00	1	60.00
Caja de lapiceros	10.00	1	10.00
Perforadora	20.00	1	20.00
Caja de lápices	20.00	1	20.00
Engrapador	35.00	1	35.00
USB	30.00	1	30.00
Maqueta de seno	50.00	2	100.00
Servicios			
Movilidad	-	-	800.00
Servicio de internet	60.00	8	480.00
Alimentación	-	-	500.00
COSTO TOTAL FINAL			2,955.00

3.3. Recursos disponibles

MATERIALES	RECURSOS HUMANOS
Laptop y otros equipos	Investigadora

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Lactancia materna [internet]. [consultado el 20 de julio 2023]
Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
2. Gobierno Regional de Huancavelica. La leche materna es el primer alimento, el más completo e irremplazable para el recién nacido [internet]. Gob. pe. [consultado el 20 de julio 2023].
Disponible en:
<https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica/noticias/643606-la-leche-materna-es-el-primer-alimento-el-mas-completo-e-irremplazable-para-el-recien-nacido>
3. Unicef. Lactancia materna [internet]. [consultado el 20 de julio 2023]. Disponible en:
<https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna>
4. Organización Panamericana de la Salud. Lactancia materna y alimentación complementaria [internet]. OMS. [21 de julio 2023]. Disponible en:
<https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria#:~:text=La%20lactancia%20materna%20ayuda%20a,diabetes%20tipo%20%20en%2035%25>
5. APILAM. Artritis Reumatoide (AR) Materna. En: e-lactancia.org. APILAM: Asociación para la promoción e investigación científica y cultural de la lactancia materna; 2002 actualizado 11 feb 2020; acceso 26 jun 2023. Disponible en
<https://e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-rheumatoid-arthritis-ra/product/>
6. CEPLAN. Observatorio Nacional de Prospectiva [Internet]. Gob.pe. [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/ts_3_salud
7. ENDES. ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR 2023 [Internet]. Gob.pe. 2024 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1950/libro.pdf
8. Masapanta J, Alvear M. Estrategias educativas en la promoción de la lactancia Materna en madres primerizas [Internet]. Researchgate.net. 2023 [consultado el 4 de enero del 2025]. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/370590441_Estrategias_educativas_en_la_promocion_de_la_lactancia_Materna_en_madres_primerizas
9. Angulo N, Salazar A. EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EN GESTANTES Y PUÉRPERAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL III GOYENECHE, NOVIEMBRE, AREQUIPA-2022 [Internet]. Edu.pe. 2022 [consultado el 5 de enero del 2025]. Disponible en:
<https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4f1e543f-2821-4d0e-85ec-912acf6f6991/content>

10. Minsa. NORMA TECNICA DE SALUD de La Gestante Adolescente Durante El Embarazo AIYD, Puerperio PAY. [Internet]. Gob.pe. [Consultado el 26 de junio 2023]. Disponible en:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1226916/501320200811-2899800-16p2oki.pdf?v=1597184421>
11. Ministerio de Salud. Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna [internet]. Actualizado 2015. [consultado el 21 de julio 2023] Disponible en:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471230/130173163268756829820191231-7797-gbg6j.pdf?v=1577827973>
12. Ministerio de Salud. Reglamento de Alimentación Infantil [internet]. Actualizado el 2006. [Consultado el 21 junio del 2023]. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4922.pdf>
13. HOSPITAL SANTA ROSA. REGLAMENTO DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA - 2024 [Internet]. Gob.pe. 2024 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6498290/5670507-rd-143-2024-dg-hsr-minsa.pdf>
14. MINSA. NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA NIÑA Y EL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS [Internet]. Gob.pe. 2017 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://www.saludarequipa.gob.pe/archivos/cred/NORMATIVA%20CRED.pdf>
15. Charu S, et. ENHANCING BREASTFEEDING PRACTICAS THROUGH A BIOPOLYMER-BASED EDUCATIONAL INTERVENTION [Internet]. Researchgate.net. 2025 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
https://www.researchgate.net/profile/Kanchan-Bala-2/publication/390253730_Enhancing_Breastfeeding_Practices_Through_a_Biopolymer-Based_Educational_Intervention/links/67e6400c920b736ca9b33385/Enhancing-Breastfeeding-Practices-Through-a-Biopolymer-Based-Educational-Intervention.pdf
16. Abdulahi M, Fretheim A, Argaw A, Magnus JH. Breastfeeding education and support to improve early initiation and exclusive breastfeeding practices and infant growth: A cluster randomized controlled trial from a rural Ethiopian setting. *Nutrients* [Internet]. 2021;13(4):1204. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/nu13041204>
17. López-García E. Evidencia científica de efectividad de la educación para la salud en la promoción de la lactancia materna [Internet]. Unirioja.es. 2020 [consultado el 4 de enero del 2025]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7509606.pdf>

18. Prihanti GS, Wilyani D, Hasna A, 'Aisy AR, Kurniawan BP, Saputri DS, et al. Effectiveness of breastfeeding counseling training to improve knowledge, attitude, and skill of support groups. J Promosi Kesehat Indones [Internet]. 2024 [consultado el 4 de enero del 2025];20(1):44–54. Disponible en: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki/article/view/61251/27254>
19. Chafalote A, Ramos W. Intervención educativa sobre el conocimiento y práctica de la lactancia materna en puérperas, Hospital Regional de Huacho-2023 [Internet]. repositorio.unjfsc.edu.pe. 2023 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/8444/TESIS%20%28ANEXO%2019%29%20CHAFALOTE-RAMOS%2023-11-2023%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
20. Ramos W. EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIAS PREVENTIVO PROMOCIONALES EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA EN GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD CLAS JORGE CHÁVEZ - JULIACA. DICIEMBRE 2020 - ABRIL 2021 [Internet]. Edu.pe. 2022 [consultado el 5 de enero del 2025]. Disponible en: https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/17974/Ramos_Condori_William_Arthur.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21. Aguirre P, Changana I. “INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO Y PRACTICAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES, PUESTO DE SALUD DE CARQUIN 2020 - 2021” [Internet]. Edu.pe. 2021 [consultado el 5 de enero del 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/4524/Aguirre%20y%20Changana.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
22. Aguilar B. EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA EL ÉXITO DE LACTANCIA MATERNA EN PUÉRPERAS ADOLESCENTES DEL HOSPITAL SERGIO E. BERNALES, 2020 [Internet]. Edu.pe. 2020 [consultado el 5 de enero del 2025]. Disponible en: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/6122/TESIS_AGUILAR_PAJUEL_O_BLANCA_ELVIRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
23. Manero, P; Pazos, R; Calleja, J. Mantenimiento de la lactancia materna en el hogar. Actualizado el 2021. [Consultado el 22 de junio 2023]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/mantenimiento-de-la-lactancia-materna-en-el-hogar/>
24. Itchart L, Donati J. Prácticas culturales [Internet]. Edu.ar. 2014 [Consultado el 26 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://www.unaj.edu.ar/wp-content/uploads/2017/02/Practicas_culturales_2014.pdf

25. Pérez O. La teoría de lo cotidiano de Michel de Certeau aplicada a Primavera tardía de Ozu y Un condenado a muerte se ha escapado de Bresson [Internet]. Ull.es. 2020 [Consultado el 26 de diciembre de 2024]. Disponible en:
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/21988/La%20teoria%20de%20lo%20cotidiano%20de%20Michel%20de%20Certeau%20aplicada%20a%20Primavera%20tardia%20de%20Ozu%20y%20Un%20condenado%20a%20muerte%20se%20ha%20escapado%20de%20Bresson.pdf;jsessionid=B17C2F9FE78F67F0F6E1A99CD7FB8C76?sequence=1>
26. Aguilar O, et. Madeleine Leininger: un análisis de sus fundamentos teóricos [Internet]. Bvsalud.org. 2007 [Consultado el 26 de diciembre de 2024]. Disponible en:
[https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/01/1028455/457-manuscrito-anonimo-871-1-10-20180417.pdf#:~:text=SUSTENTOS%20TE%3%93RICOS%20DE%20LEININGER,sociocultural%20\(Ver%20cuadro%201\)](https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/01/1028455/457-manuscrito-anonimo-871-1-10-20180417.pdf#:~:text=SUSTENTOS%20TE%3%93RICOS%20DE%20LEININGER,sociocultural%20(Ver%20cuadro%201))
27. Minsa. Rotafolio lactancia materna. Gob pe. 2015. [Consultado el 22 junio del 2023] Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/402800/ROTAFOLIO002.pdf>
28. Brahm Paulina, Valdés Verónica. Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Rev. chil. pediatr. [Internet]. 2017 [citado 2025 Jun 02] ; 88(1): 07-14. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001&lng=es.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062017000100001>.
29. Alvarado L, Guarín L, Cañón W. Vista de Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo: reporte de caso en la unidad materno infantil [Internet]. Edu.co. 2011 [Consultado el 26 de diciembre de 2024]. Disponible en:
<https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/57/62>
30. Elevit. Tipos de leche materna [internet] [Consultado el 22 de junio del 2023]. Disponible en:
<https://www.elevit.com.mx/mama-primeriza/tipos-de-leche-materna>
31. Dificultades técnicas en la lactancia materna [Internet]. Pediatría integral. 2025 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2025-03/dificultades-tecnicas-en-la-lactancia-materna/>
32. Manero, P; Pazos, R; Calleja, J. Mantenimiento de la lactancia materna en el hogar. Actualizado el 2021. [Consultado el 22 de junio 2023]. Disponible en:
<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/mantenimiento-de-la-lactancia-materna-en-el-hogar/>
33. Espínola JPS. Conocimiento - Qué es, fuentes, tipos y teoría. [consultado el 5 de enero del 2025]; Disponible en: <https://concepto.de/conocimiento/>

34. ¿Qué es el concepto de conocimiento? [Internet]. Euroinnova International Online Education. 2024 [consultado el 15 de diciembre del 2024]. Disponible en:
<https://www.euroinnova.com/blog/por-que-es-importante-el-conocimiento>
35. Altamirano E. Conocimiento y práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses en un centro de salud de primer nivel de atención Lima 2022 [Internet]. repositorio.uwiener.edu.pe. 2022 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e4d3db57-ab8b-4ef1-a020-cc02e8f7b619/content>
36. Hernández Aguilar MT, Aguayo Maldonado J, Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. La lactancia materna. Cómo promover y apoyar la lactancia materna en la práctica pediátrica. Recomendaciones del Comité de Lactancia de la AEP. An Pediatr (Barc) [Internet]. 2005;63(4):340–56. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1157/13079817>
37. Porto JP, Gardey A. Práctica [Internet]. Definicion.de. Definicion.de; 2010 [consultado el 18 de diciembre del 2024]. Disponible en: <https://definicion.de/practica/>
38. Montes E. ¿Realmente la práctica perfecciona el aprendizaje? [Internet]. D2L. 2021 [consultado el 18 de diciembre del 2024]. Disponible en: <https://www.d2l.com/es/blog/realmente-la-practica-perfecciona-el-aprendizaje/>
39. OMS, UNICEF. Indicadores para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y del niño pequeño [Internet]. Who.int. 2022 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/378148/9789240048591-spa.pdf?sequence=4>
40. Leon J. Importancia de la consultoría en lactancia materna [Internet]. Clinicasanfelipe.com. 2024 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://www.clinicasanfelipe.com/blog/importancia-de-la-consultoria-en-lactancia-materna#:~:text=Apoyo%20Emocional:%20Ofrecen%20apoyo%20emocional,ser%20un%20proceso%20emocionalmente%20desafiante>
41. Aponte-Franco S, et. Vista de Reflexiones de los 4 roles de enfermería e impactos en América Latina [Internet]. Edu.co. 2023 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en:
<https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/3503/4403>
42. Forero T Y, et. Rol de enfermería durante la lactancia materna en el primer año de vida Nursing role during breastfeeding in the first year of life Papel da enfermagem durante a amamentação no primeiro ano de vida. Rev Chil Pediatr [Internet]. 2018;89(5):612–20. Disponible en:
<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/5076/pdf#:~:text=El%20rol%20de%20enfermer%C3%ADa%20en,durante%20el%20parto%20y%20posparto>

43. Weedon, C. (1991/1987). Book review: The everyday world as problematic. A feminist sociology, by Dorothy E. Smith. Boston: Northeastern university press, 1987. Critical Sociology, 18(1), 137–139. [Consultado el 14 de enero del 2025] Disponible en: <https://doi.org/10.1177/089692059101800112>
44. Aristizábal Hoyos GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostiguín Meléndez RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender: Una reflexión en torno a su comprensión. Enferm Univ [Internet]. 2011 [Consultado el 26 de diciembre de 2024];8(4):16–23. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003
45. Alvarado L, Guarín L, Cañón W. Vista de Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo: reporte de caso en la unidad materno infantil [Internet]. Edu.co. 2011 [Consultado el 26 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/57/62>
46. Velásquez S, Huaman D. Efectos del cuidado enfermero basado en teoría de Kristen Swanson sobre conocimientos y aceptación de lactancia materna en primigestas [Internet]. Medigraphic.com. 2020 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubenf/cnf-2020/cnf204o.pdf>
47. Gonzalo A. Hildegard Peplau: Interpersonal Relations theory [Internet]. Nurseslabs. 2014 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: <https://nurseslabs.com/hildegard-peplaus-interpersonal-relations-theory/>
48. Hernández R. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN [Internet]. Www.uv.mx. 1997 [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/metodologia-de-la-investigaci%C3%83%C2%B3n_sampieri.pdf
49. Universidad de Colima. Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta [Internet]. Ucol.mx. [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: <https://recursos.ucol.mx/tesis/investigacion.php>

ANEXOS

Matriz de consistencia del Proyecto

Efectividad del Programa de consejería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025					
Preguntas	Objetivos	Hipótesis	Variable/Indicadores	Población	Metodología
Pregunta general: ¿Cuál es la efectividad del programa de consejería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones en el año 2025?	Objetivo general: Determinar la efectividad del programa de consejería “Lactancia de amor” en los conocimientos y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones en el año 2025.	Hipótesis nula: El programa de consejería “Lactancia de amor” no es efectiva en los conocimientos y práctica de las madres sobre LME.	V. dependiente 1: Conocimientos sobre LME · Aspectos generales · Beneficios para el bebé · Beneficios para la madre · Tipos de leche · Técnica de lactancia	Se tomará a toda la población que cumpla con los criterios de inclusión y acepte participar en el estudio. (población censal)	Estudio cuantitativo, explicativo y cuasiexperimental.
Preguntas específicas: ¿Es viable modificar conocimientos y prácticas de las madres sobre lactancia materna exclusiva?, ¿Es posible mejorar los conocimientos al aplicar un programa de consejería sobre lactancia materna exitosa?, ¿Es posible mejorar las prácticas de la lactancia materna al aplicar un programa de consejería sobre lactancia materna exclusiva?	Objetivos específicos: · Identificar los conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de participar en el programa “Lactancia de amor”. · Ejecutar el programa de consejería “Lactancia de amor” en madres primíparas. · Identificar el tipo de prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de participar en el programa “Lactancia de amor”.	Hipótesis alterna: El programa de consejería “Lactancia de amor” es efectiva en los conocimientos y práctica de las madres sobre LME.	V. dependiente 2: Prácticas de LME · Ánimo de la madre · Ánimo de la o del bebé · Apariencia de los pechos · Posición de la madre · Posición del(a) bebé · Agarre del(a) bebé · Succión del(a) bebé		Instrumentos: Cuestionario pre-post test Ficha de observación

Instrumento
CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD
MIRONES, 2025

I. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, egresada de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

II. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

III. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.
 - a) Verdadero

- b) Falso
- c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

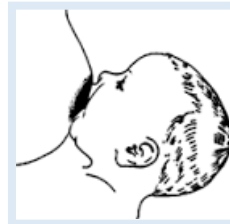
11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta

a)	b)	c) No se
		

14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

d) De cuna	e) Acostada	f) No se
		

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo	b) Brazo opuesto	c) No se
		

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Nombre de la madre: _____ Fecha: _____

Nombre del bebé: _____ Edad del bebé: _____

Signos de que la LME se practica bien		Signos de dificultad en la práctica de la LME	
Madre: • Luce saludable • Relajada y cómoda • Signos de apego entre madre y bebé	☐ ☐ ☐	Madre: • Luce enferma o deprimida • Luce tensa e incómoda • No EXISTE contacto visual madre y bebé	☐ ☐ ☐
Bebé: • Luce saludable • Calmado y relajado • Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	☐ ☐ ☐	Bebé: • Luce somnolienta/o y enfermera/o • Inquieto y/o llorando • No alcanza ni busca el pecho	☐ ☐ ☐
Pechos: • Pechos blandos, piel luce sana • No dolor ni incomodidad • Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	☐ ☐ ☐	Pechos: • Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados • Pechos o pezones dolorosos • Pecho sostenido con dedos en la areola • Pezones aplastados, deformados, después de la mamada	☐ ☐ ☐ ☐
Posición de la o el bebé: • Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados • Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre • Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	☐ ☐ ☐	Posición de la o el bebé: • Cuello y cabeza torcidos para mamar • Bebé separado de la madre • Solo apoyados la cabeza y cuello • Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón	☐ ☐ ☐ ☐
Agarre de la o el bebé al pecho: • Más areola sobre el labio superior de la o el bebé • Boca de la o el bebé bien abierta • Labio inferior volteado hacia afuera • Mentón de la o el bebé toca el pecho	☐ ☐ ☐ ☐	Agarre de la o el bebé al pecho: • Más areola debajo el labio superior de la o el bebé • Boca de la o el bebé no está abierta • Labios hacia adelante o hacia adentro • Mentón de la o el bebé no toca el pecho	☐ ☐ ☐ ☐
Succión: • Mamadas lentas y profundas, con		Succión: • Mamadas rápidas y superficiales	☐

• pausas • Mejillas redondeadas cuando succiona • La o el bebé suelta el pecho cuando termina • Madre nota signos del reflejo de oxitocina	() () () ()	• Mejillas chupadas hacia dentro • La madre retira a la o el bebé del pecho • La madre no nota signos del reflejo de oxitocina	() () () ()
NOTAS:			

Cálculo de Coeficiente de Validez de Contenido

CUESTIONARIO

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

7 JUECES

Item	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	S xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	5	4	5	4	5	5	33	6.6000	0.9429	0.0000012143	0.9429
2	5	3	4	5	4	5	5	31	6.2000	0.8857	0.0000012143	0.8857
3	5	3	3	5	3	5	5	29	5.8000	0.8286	0.0000012143	0.8286
4	5	5	4	5	5	5	5	34	6.8000	0.9714	0.0000012143	0.9714
5	5	5	5	5	5	5	5	35	7.0000	1.0000	0.0000012143	1.0000
6	5	5	4	5	4	4	5	32	6.4000	0.9143	0.0000012143	0.9143
7	5	3	5	5	4	5	5	32	6.4000	0.9143	0.0000012143	0.9143
8	5	5	5	3	3	4	5	30	6.0000	0.8571	0.0000012143	0.8571
9	5	5	4	3	4	5	5	31	6.2000	0.8857	0.0000012143	0.8857
10	5	3	4	3	2	5	5	27	3.8571	0.5510	0.0000012143	0.5510
11	5	3	4	3	4	3	4	26	5.2000	0.7429	0.0000012143	0.7429
12	5	3	4	3	5	5	4	29	5.8000	0.8286	0.0000012143	0.8286
13	5	3	5	5	5	5	5	33	6.6000	0.9429	0.0000012143	0.9429
14	5	3	5	5	4	4	5	31	6.2000	0.8857	0.0000012143	0.8857
15	5	3	4	5	4	5	5	31	6.2000	0.8857	0.0000012143	0.8857
16	5	5	5	5	5	5	5	35	7.0000	1.0000	0.0000012143	1.0000
17	5	3	4	5	3	4	5	29	5.8000	0.8286	0.0000012143	0.8286
18	5	3	4	5	3	4	5	29	5.8000	0.8286	0.0000012143	0.8286

	S	15.6939
n de ítems	18	CVct
		0.8719
		CVctc
		0.8719

Nota: Si se tiene más preguntas, insertar filas y copiar las funciones de cálculo, mantenga el Pei y actualice el n de ítems. Si tiene menos ítems, simplemente elimine filas.

INTERPRETACIÓN DEL CÁLCULO DEL CVC

Valor del CVC	Interpretación de la validez y concordancia
De 0 a 0,60	Inaceptable
Mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70	Deficiente
Mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80	Aceptable
Mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90	Buena
Mayor a 0,90	Excelente

Fuente: Hernández-Nieto (2011)

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

5 JUECES

Item	J1	J2	J3	J4	J5	S xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	5	3	5	5	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797
2	4	5	3	5	5	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797
3	4	5	3	5	5	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797
4	4	5	4	5	5	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197
5	4	5	4	5	5	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197
6	4	5	3	5	5	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797

	S	5.3582
n de ítems	6	CVct
		0.8930
		CVctc
		0.8927

Nota: Si se tiene más preguntas, insertar filas y copiar las funciones de cálculo, mantenga el Pei y actualice el n de ítems. Si tiene menos ítems, simplemente elimine filas.

INTERPRETACIÓN DEL CÁLCULO DEL CVC

Valor del CVC	Interpretación de la validez y concordancia
De 0 a 0,60	Inaceptable
Mayor a 0,60 y menor o igual a 0,70	Deficiente
Mayor a 0,70 y menor o igual a 0,80	Aceptable
Mayor a 0,80 y menor o igual a 0,90	Buena
Mayor a 0,90	Excelente

Fuente: Hernández-Nieto (2011)

Formato de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada señora

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado “Efectividad de la consejería de enfermería en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del centro de salud Mirones, Lima-Perú, 2025”

El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de la consejería de enfermería en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del centro de salud Mirones, Lima-Perú, 2025

Si usted acepta participar en este estudio, se le solicitará que responda un cuestionario de entrada, que contiene preguntas sobre lactancia materna exclusiva, el cuestionario en sí le tomará aproximadamente 15 minutos, en mayo, junio o julio, según corresponda. Además, se aplicará una lista de cotejo para la evaluación de la mamada de su hijo. Posterior a ellos, se le brindará tres sesiones de consejería de enfermería sobre lactancia materna exclusiva que se acuerde a la disponibilidad. Finalmente de las tres sesiones, se le solicitará que responda un segundo cuestionario de salida que tomará aproximadamente 15 minutos.

La participación en esta actividad es voluntaria y no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental. Usted puede negarse a participar en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello, ni recibir ningún tipo de sanción.

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato, estos datos serán organizados con un número asignado a cada participante, la identidad de las madres se mantendrá completamente confidencial. Los datos estarán a cargo del investigador de este estudio para el posterior desarrollo de informes y publicaciones dentro de revistas científicas.

Si Usted no desea participar no implica sanción. Usted tiene el derecho a negarse a responder a preguntas concretas, también puede optar por retirarse de este estudio en cualquier momento y la información que hemos recogido será descartada del estudio y eliminada.

Cabe destacar que no existe ningún riesgo al participar de este estudio.

Cualquier pregunta que Usted desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar al Celular: 910777150, Correo electrónico: yemmy.santos@unmsm.edu.pe

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,....., acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación **“Efectividad de la consejería de enfermería en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del centro de salud Mirones, Lima-Perú, 2025”**, dirigida por Yemmy Eliane Santos Chinguel, Responsable de la investigación.

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación.

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.

Declaro saber que la información entregada será **confidencial y anónima** y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de cada participante de modo personal.

Declaro saber que la información que se obtenga será guardada por el investigador responsable y será utilizada sólo para este estudio.

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

Firma participante

Firma investigador

Fecha:

PROGRAMA “LACTANCIA DE AMOR”

1. INTRODUCCIÓN

Si bien la tasa de la lactancia materna exclusiva (LME) presenta un avance significativo a nivel internacional en el período 2012 al 2022 del 37,1% al 48%, con la misma tendencia en Latinoamérica y El Caribe del 34,3% al 43,1%. El incremento de la tasa de LME en el Perú no resulta ser significativo siendo del 68,5% al 69,3% desde el 2009 al 2023, según el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) (1). Acorde a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la leche materna es beneficiosa para el lactante y la madre por su enriquecido aporte nutricional, anticuerpos y fortalecimiento en el vínculo afectivo madre-hijo (2,3). Es importante seguir implementando políticas que promuevan y apoyen la LME para el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños peruanos; para ello, se recomienda fortalecer campañas educativas para la reducción de las brechas en acceso de la información en las madres según el Observatorio del CEPLAN (1). Estudios internacionales como Masapanta y Alvear (4), y estudios nacionales como Angulo y Salazar (5) evidencian que las estrategias educativas implementadas aumentaron los conocimientos y fortalecieron las prácticas de LME en las madres participantes.

2. OBJETIVOS

- Aumentar los conocimientos sobre LME en madres primíparas.
- Mejorar las prácticas de LME en madres primíparas.
- Promover la lactancia materna en madres primíparas.

3. METODOLOGÍA

La metodología a utilizar es la consejería. Acorde a la Guía Técnica para la Consejería en Lactancia Materna (6), la consejería se basa en 5 momentos para su desarrollo:

Momento 1: Inicio de la consejería

Es el punto de partida de la consejería, se debe de ganar la confianza de la madre para su participación activa. Se inicia con el saludo y presentación del responsable, se indaga

sobre el estilo de vida, ocupación e incluso del día a día de la madre para entrar en un ambiente de confianza.

Momento 2: Búsqueda de los factores causales o de riesgos

Se comienza con la búsqueda de dificultades que tenga la madre respecto a la lactancia de la madre. Es importante estar atentos, escuchar activamente y ser respetuosos a los pensamientos y creencias de la madre.

Momento 3: Reforzar la confianza y dar apoyo

Se le brinda la información adecuada respecto a las dudas o brechas de conocimientos que tenga la madre. Este con el objetivo de orientar a la madre a una toma de decisiones informada.

Momento 4: Registro de la consejería

Se realiza el registro de la sesión de la consejería en la ficha clínica o registro de atención que corresponda.

Momento 5: Cierre y seguimiento

Se realizará el cierre de la sesión mediante acuerdos que realizará la madre y se coordinará la fecha de la próxima sesión a realizar. Es crucial cerciorarse que no queden dudas y cerrar la sesión de manera cálida para mantener el vínculo con la madre.

4. RESPONSABLE

Yemmy Eliane Santos Chinguel

5. TÉCNICAS

- A. Observación
- B. Entrevista estructurada presencial

6. INSTRUMENTOS

- A. “Ficha de Observación de la Mamada”

Es la ficha de observación extraída de la Guía Técnica sobre la consejería en lactancia materna (ANEXO 1). Tiene el objetivo de identificar la práctica en el amamantamiento de las madres.

- B. “Cuestionario para madres primíparas del Centro de Salud Mirones, 2025”

Cuestionario que tiene como objetivo identificar los conocimientos sobre LME en las madres primíparas (ANEXO 2)

7. MATERIALES

- Consentimiento informado (ANEXO 3)
- “Ficha de Observación de la Mamada” (ANEXO 1)
- “Cuestionario para madres primíparas del Centro de Salud Mirones, 2025” (ANEXO 2)
- Rotafolio (ANEXO 4)
- Fichas resumen de las sesiones (ANEXO 5)
- Maqueta de lactancia (ANEXO 6)
- Bitácora (ANEXO 7)

8. POBLACIÓN

La población consta de 30 madres primíparas.

9. LUGAR

- Centro de Salud de Mirones
- Hogares de las madres

10. CAPÍTULO I: CONTACTO

Se realiza la recolección de madres primíparas con los datos de contacto brindados por el centro de salud como:

- Nombre de la madre y nombre del padre/acompañante en caso participe en el cuidado del niño(a)
- Nombre del niño(a)
- Edad del niño(a)
- Número de celular de la madre y el número de celular del padre/acompañante en caso participen en el cuidado del niño(a)
- Dirección

Se realiza el primer contacto mediante WhatsApp para solicitar la autorización para participar en el programa. Se le citará a la madre a la primera sesión en el Centro de Salud de Mirones para la presentación y explicación del programa a participar y el llenado del consentimiento informado (ANEXO 3).

11. CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL PROGRAMA

Sesión 1:

Posterior a la autorización en la participación en el programa, se aplicará el cuestionario para identificar los conocimientos sobre LME en las madres; además, se le pedirá realizar el amamantamiento para aplicar la ficha de observación para evaluar las dificultades que pueda presentar la madre al alimentar a su hijo; todo en un lapso de 15 minutos. Se procederá con el desarrollo de la primera sesión con la Unidad I “Aspectos generales de la lactancia materna” y Unidad II “¿Cuáles son los beneficios?” usando el rotafolio y aplicando los 5 momentos de la consejería, en un lapso de 30 minutos. Se realizará la retroalimentación de lo aprendido en la sesión en un lapso de 10 minutos, se le brindará ficha resumen de la sesión y el cierre con 2 acuerdos máximos a realizar por parte de la madre y la fecha a realizar la segunda sesión en un lapso de 15 días. Se registra la sesión 1 en la bitácora del estudio.

Sesión 2:

Se hará inicio de la sesión con la dinámica “¿Qué recordamos?” con el objetivo de evocar lo aprendido en la sesión anterior por 10 minutos. Se procederá con el desarrollo de la segunda sesión con la Unidad III “Tipos de lactancia” usando el rotafolio y los 5 momentos de la consejería, en un lapso de 30 minutos. Se retroalimentará a la madre sobre lo aprendido en la sesión en 10 minutos, se le brindará la ficha resumen de la sesión y el cierre se establecerá como máximo 2 acuerdos que realizará la madre y la fecha de la sesión 3 en un lapso de 15 días. Se registra la sesión 2 en la bitácora.

Sesión 3:

Se hará inicio de la sesión con la dinámica “¿Qué recordamos?” con el objetivo de evocar lo aprendido en la sesión anterior por 10 minutos. Se procederá con el desarrollo de la

segunda sesión con la Unidad IV “Tipos de leche” usando el rotafolio y los 5 momentos de la consejería, en un lapso de 30 minutos. Se retroalimentará a la madre sobre lo aprendido en la sesión en 10 minutos, se le brindará la ficha resumen de la sesión y el cierre se establecerá como máximo 2 acuerdos que realizará la madre y la fecha de la sesión 4 en un lapso de 15 días. Se registra la sesión 3 en la bitácora.

Sesión 4:

Se hará inicio de la sesión con la dinámica “¿Qué recordamos?” con el objetivo de evocar lo aprendido en la sesión anterior por 10 minutos. Se procederá con el desarrollo de la segunda sesión con la Unidad V “¿Cómo amamantar?” usando el rotafolio y los 5 momentos de la consejería, en un lapso de 30 minutos. Se retroalimentará a la madre sobre lo aprendido en la sesión en 10 minutos, se le brindará la ficha resumen de la sesión y el cierre se establecerá como máximo 2 acuerdos que realizará la madre y la fecha de la última sesión en un lapso de 15 días. Se registra la sesión 4 en la bitácora.

Sesión 5:

Se hará inicio de la sesión con la dinámica “¿Qué recordamos?” con el objetivo de evocar lo aprendido en la sesión anterior por 10 minutos. Se procederá con el desarrollo de la segunda sesión con la Unidad VI “Posiciones de lactancia” usando el rotafolio y los 5 momentos de la consejería, en un lapso de 30 minutos. Se retroalimentará a la madre sobre lo aprendido en la sesión en 10 minutos, se le brindará la ficha resumen de la sesión y el cierre se establecerá como máximo 2 acuerdos que realizará la madre. Siendo esta la última sesión del programa, se procederá a aplicar el cuestionario y la ficha de observación para identificar los conocimientos y prácticas, respectivamente, sobre LME posterior a la aplicación del programa por 15 minutos.

12. ESQUEMA DEL PROGRAMA

PROGRAMA “LACTANCIA DE AMOR”

Objetivos:

- Aumentar los conocimientos sobre LME en madres primíparas.
- Mejorar las prácticas de LME en madres primíparas.
- Promover la lactancia materna exclusiva en madres primíparas.

POBLACIÓN: 30 madres primíparas

LUGAR: Centro de Salud Mirones

METODOLOGÍA: Consejería

ETAPA

DESARROLLO

TIEMPO

MATERIALES

I. CONTACTO

Se realizará el contacto por vía WhatsApp con los datos brindados por el centro para la participación del programa y programar la primera sesión.

6 meses

Celular

II. DESARROLLO DEL PROGRAMA

Sesión
1

- “Aspectos generales de la lactancia materna”
- “¿Cuáles son los beneficios?”

La madre llega a la primera sesión en el Centro de Salud Mirones con su menor hijo. Se realiza el saludo y presentación del responsable y el programa.
Responsable: Buen día/Buenas tardes, señora. Soy la bachiller de Enfermería Yemmy Eliane Santos Chinguel, encargada de realizar el programa “Lactancia de amor”. Se le agradece su valiosa participación en el programa, este programa tiene como objetivos aumentar los conocimientos sobre LME, mejorar las prácticas y promover la LME.

La madre responde al saludo.
Responsable: Antes de comenzar con el programa le pido encarecidamente que pueda brindar su consentimiento y autorización para poder participar en el

15 minutos

- Consentimiento informado
- “Cuestionario para madres primíparas del Centro de Salud Mirones, 2025”

			programa mediante el consentimiento informado. Recordar que la participación en este programa es totalmente anónima y confidencial. La madre brinda su autorización y consentimiento. <i>Responsable:</i> Comenzando con el programa, contestaremos el cuestionario, posterior a ello, me demostraría la mamada que realiza con su hijo para poder identificar mejoras que se podría realizar. La madre responde el cuestionario y realiza la demostración de la mamada, el responsable hará uso de la ficha de observación de la mamada para evaluar dificultades que presenta la madre al alimentar a su hijo.		- Ficha de observación de la mamada
			Momento 1: El responsable vuelve a presentarse, indagará más sobre la madre y el hijo como la ocupación de la madre, el estado civil y si tiene apoyo del padre de su hijo o algún acompañante. Momento 2: Se indagará sobre lo que sabe de la madre respecto a qué es la LME y sus beneficios. <i>Responsable:</i> “¿Usted sabe qué es la lactancia?” “¿Qué es la lactancia materna exclusiva para usted?” “¿Por qué es importante la lactancia materna?” “¿Qué beneficios tiene la lactancia materna?” Momento 3: Acorde a las respuestas de las madres, se le brindará la información relacionada a qué es la lactancia materna, lactancia materna exclusiva, su importancia y beneficios. Momento 4: Se realiza el registro de la consejería en la bitácora.	30 minutos	Rotafolio

			Momento 5: Se realiza el cierre de la consejería mediante 2 acuerdos a realizar por parte de la madre y se programará la siguiente sesión en un plazo de 15 días.		
			Al finalizar la sesión, se realizará una resumen de lo aprendido en la sesión con “¿Qué aprendimos hoy?” en donde se reforzará lo aprendido sobre qué es la lactancia materna, lactancia materna exclusiva, su importancia y beneficios. Se le brindará la ficha resumen de la sesión.	10 minutos	Ficha resumen Sesión 1
	Sesión 2	“Tipos de lactancia”	La madre llega a la segunda sesión en el Centro de Salud. Se le saluda, se le agradece la continuidad del programa y se realiza un recordatorio de lo aprendido en la sesión anterior con el “¿Qué recordamos?” <i>Responsable:</i> Buen día / Buenas tardes, señora. Gracias por asistir a la segunda sesión del programa. ¿Cómo se ha encontrado usted y su bebé? La madre responde. <i>Responsable:</i> Para recordar lo aprendido en la sesión anterior, realizaremos una dinámica llamada “¿Qué recordamos?”, ¿Recuerda lo que hemos aprendido la sesión anterior? La madre responde lo que recuerde de lo aprendido la sesión anterior y lo que no, se le reforzará para consolidar los conocimientos.	10 minutos	-
			Momento 1: Se le preguntará a la madre cómo se va acoplando a la maternidad y la lactancia para poder entrar en confianza con ella.	30 minutos	Rotafolio

			Momento 2: Se indagará sobre lo que sabe de la madre respecto a los tipos de lactancia. <i>Responsable:</i> “¿Usted sabía sobre los tipos de lactancia?” “¿Sabe cuáles son esos tipos de lactancia?” “¿Por qué es importante saber sobre esos tipos de lactancia?” Momento 3: Acorde a las respuestas de las madres, se le brindará la información relacionada a los tipos de lactancia. Momento 4: Se realiza el registro de la consejería en la bitácora. Momento 5: Se realiza el cierre de la consejería mediante 2 acuerdos a realizar por parte de la madre y se programará la siguiente sesión en un plazo de 15 días.		
			Al finalizar la sesión, se realizará una resumen de lo aprendido en la sesión con “¿Qué aprendimos hoy?” en donde se reforzará lo aprendido sobre los tipos de lactancia. Se le brindará la ficha resumen de la sesión.	10 minutos	Ficha resumen sesión 2
	Sesión 3	“Tipos de leche”	La madre llega a la tercera sesión en el Centro de Salud. Se le saluda, se le agradece la continuidad del programa y se realiza un recordatorio de lo aprendido en la sesión anterior con el “¿Qué recordamos?” <i>Responsable:</i> Buen día / Buenas tardes, señora. Gracias por asistir a la tercera sesión del programa. ¿Cómo se ha encontrado usted y su bebé? La madre responde.	10 minutos	-

			<i>Responsable:</i> Para recordar lo aprendido en la sesión anterior, realizaremos una dinámica llamada “¿Qué recordamos?”, ¿Recuerda lo que hemos aprendido la sesión anterior? La madre responde lo que recuerde de lo aprendido la sesión anterior y lo que no, se le reforzará para consolidar los conocimientos.		
			Momento 1: Se le preguntará a la madre cómo se va acoplando a la maternidad y la lactancia para poder entrar en confianza con ella. Momento 2: Se indagará sobre lo que sabe de la madre respecto a los tipos de leche. <i>Responsable:</i> “¿Usted sabía sobre los tipos de leche materna?” “¿Sabe cuáles son esos tipos de leche?” “¿Qué sabe usted sobre el calostro?” “¿Cuál es la diferencia de estos tipos de leche?” Momento 3: Acorde a las respuestas de las madres, se le brindará la información relacionada a los tipos de lactancia. Momento 4: Se realiza el registro de la consejería en la bitácora. Momento 5: Se realiza el cierre de la consejería mediante 2 acuerdos a realizar por parte de la madre y se programará la siguiente sesión en un plazo de 15 días.	30 minutos	Rotafolio
			Al finalizar la sesión, se realizará una resumen de lo aprendido en la sesión con “¿Qué aprendimos hoy?” en donde se reforzará lo aprendido sobre los	10 minutos	Ficha resumen sesión 3

			tipos de leche. Se le brindará la ficha resumen de la sesión.		
	Sesión 4	“¿Cómo amamantar?”	Se realiza la primera visita domiciliaria para la cuarta sesión del programa. Se le saluda, se le agradece la continuidad del programa y se realiza un recordatorio de lo aprendido en la sesión anterior con el “¿Qué recordamos?” <i>Responsable:</i> Buen día / Buenas tardes, señora. Gracias por recibirme para la cuarta sesión del programa. ¿Cómo se ha encontrado usted y su bebé? La madre responde. <i>Responsable:</i> Para recordar lo aprendido en la sesión anterior, realizaremos una dinámica llamada “¿Qué recordamos?”, ¿Recuerda lo que hemos aprendido la sesión anterior? La madre responde lo que recuerde de lo aprendido la sesión anterior y lo que no, se le reforzará para consolidar los conocimientos.	10 minutos	-
			Momento 1: Se le preguntará a la madre cómo se va acoplando a la maternidad y la lactancia para poder entrar en confianza con ella. Momento 2: Se indagará sobre lo que sabe de la madre respecto a cómo amamanta a su bebé. <i>Responsable:</i> “¿Cómo se tendría que comenzar al momento de lactar?” “¿Ha escuchado sobre la mano en “C”?” “¿Cómo tendría que tener la boca su bebé al lactar?” “¿Es normal que duela al momento de lactar?” Momento 3: Acorde a las respuestas de las madres, se le brindará la	30 minutos	- Rotafolio - Maqueta de lactancia

			información relacionado a cómo amamantar a su bebé. Momento 4: Se realiza el registro de la consejería en la bitácora. Momento 5: Se realiza el cierre de la consejería mediante 2 acuerdos a realizar por parte de la madre y se programará la siguiente sesión en un plazo de 15 días.		
			Al finalizar la sesión, se realizará una resumen de lo aprendido en la sesión con “¿Qué aprendimos hoy?” en donde se reforzará lo aprendido sobre cómo amamantar. Se le brindará la ficha resumen de la sesión.	10 minutos	Ficha resumen sesión 4
	Sesión 5	“Posiciones de lactancia”	Se realiza la segunda visita domiciliaria para la quinta sesión del programa. Se le saluda, se le agradece la continuidad del programa y se realiza un recordatorio de lo aprendido en la sesión anterior con el “¿Qué recordamos?” <i>Responsable:</i> Buen día / Buenas tardes, señora. Gracias por recibirme para la quinta y última sesión del programa. ¿Cómo se ha encontrado usted y su bebé? La madre responde. <i>Responsable:</i> Para recordar lo aprendido en la sesión anterior, realizaremos una dinámica llamada “¿Qué recordamos?”, ¿Recuerda lo que hemos aprendido la sesión anterior? La madre responde lo que recuerde de lo aprendido la sesión anterior y lo que no, se le reforzará para consolidar los conocimientos.	10 minutos	-

		Momento 1: Se le preguntará a la madre cómo se va acoplando a la maternidad y la lactancia para poder entrar en confianza con ella. Momento 2: Se indagará sobre lo que sabe de la madre respecto a las posiciones de lactancia. <i>Responsable:</i> “¿Sabe usted sobre las posiciones de lactancia?” “¿Ha escuchado sobre que puede dar de lactar acostada?” “¿Cómo daría de lactar una madre con mellizos o gemelos?” “¿Solo hay una posición correcta para lactar?” Momento 3: Acorde a las respuestas de las madres, se le brindará la información relacionado a las posiciones de lactancia. Momento 4: Se realiza el registro de la consejería en la bitácora. Momento 5: Se realiza el cierre de la consejería mediante 2 acuerdos a realizar por parte de la madre y se programará la siguiente sesión en un plazo de 15 días.	30 minutos	- Rotafolio - Maqueta de lactancia
		Al finalizar la sesión, se realizará una resumen de lo aprendido en la sesión con “¿Qué aprendimos hoy?” en donde se reforzará lo aprendido sobre las posiciones de lactancia. Se le brindará la ficha resumen de la sesión.	10 minutos	Ficha resumen sesión 5
		<i>Responsable:</i> Siendo la quinta y última sesión del programa de consejería, es necesario contestar el cuestionario y posterior a ello, pueda realizar la demostración del amamantamiento a su bebé.	15 minutos	- “Cuestionario para madres primíparas del

					Centro de Salud Mirones, 2025” - Ficha de observación de la mamada
--	--	--	--	--	--

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. CEPLAN. Observatorio Nacional de Prospectiva [Internet]. Gob.pe. [citado el 19 de junio de 2025]. Disponible en: https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/ts_3_salud
2. Organización Mundial de la Salud. Lactancia materna [internet]. [consultado el 20 de julio 2023] Disponible en: https://www.who.int/es/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
3. Unicef. Lactancia materna [internet]. [consultado el 20 de julio 2023]. Disponible en: <https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna>
4. Masapanta J, Alvear M. Estrategias educativas en la promoción de la lactancia materna en madres primerizas [Internet]. Researchgate.net. 2023 [consultado el 4 de enero de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370590441_Estrategias_educativas_en_la_promocion_de_la_lactancia_Materna_en_madres_primerizas
5. Angulo N, Salazar A. EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EN GESTANTES Y PUÉRPERAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL III GOYENECHÉ, NOVIEMBRE, AREQUIPA-2022 [Internet]. Edu.pe. 2022 [consultado el 5 de enero del 2025]. Disponible en: <https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4f1e543f-2821-4d0e-85ec-912acf6f6991/content>
6. Ministerio de Salud. Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna [internet]. Actualizado 2015. [consultado el 21 de julio 2023] Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471230/130173163268756829820191231-7797-gbg6j.pdf?v=1577827973>

ANEXOS

ANEXO 1. FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA

Nombre de la madre: _____ Fecha: _____

Nombre del bebé: _____ Edad del bebé: _____

Signos de que la lactancia materna funciona bien	Signos de una posible dificultad
Madre: ☐ Luce saludable ☐ Relajada y cómoda ☐ Signos de apego entre madre y bebé	Madre: ☐ Luce enferma o deprimida ☐ Luce tensa e incómoda ☐ No EXISTE contacto visual madre y bebé
Bebé: ☐ Luce saludable ☐ Calmado y relajado ☐ Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	Bebé: ☐ Luce somnolienta/o y enfermera/o ☐ Inquieto y/o llorando ☐ No alcanza ni busca el pecho
Pechos: ☐ Pechos blandos, piel luce sana ☐ No dolor ni incomodidad ☐ Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	Pechos: ☐ Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados ☐ Pechos o pezones dolorosos ☐ Pecho sostenido con dedos en la areola ☐ Pezones aplastados, deformados, después de la mamada
Posición de la o el bebé: ☐ Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados ☐ Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre ☐ Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	Posición de la o el bebé: ☐ Cuello y cabeza torcidos para mamar ☐ Bebé separado de la madre ☐ Solo apoyados la cabeza y cuello ☐ Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón
Agarre de la o el bebé al pecho: ☐ Más areola sobre el labio superior de la o el bebé ☐ Boca de la o el bebé bien abierta ☐ Labio inferior volteado hacia afuera ☐ Mentón de la o el bebé toca el pecho	Agarre de la o el bebé al pecho: ☐ Más areola debajo el labio superior de la o el bebé ☐ Boca de la o el bebé no está abierta ☐ Labios hacia adelante o hacia adentro ☐ Mentón de la o el bebé no toca el pecho
Succión: ☐ Mamadas lentas y profundas, con pausas ☐ Mejillas redondeadas cuando succiona ☐ La o el bebé suelta el pecho cuando termina ☐ Madre nota signos del reflejo de oxitocina	Succión: ☐ Mamadas rápidas y superficiales ☐ Mejillas chupadas hacia dentro ☐ La madre retira a la o el bebé del pecho ☐ La madre no nota signos del reflejo de oxitocina

NOTAS:

ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD MIRONES, 2025

I. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, egresada de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

II. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

III. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.
 - a) Verdadero

- b) Falso
- c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

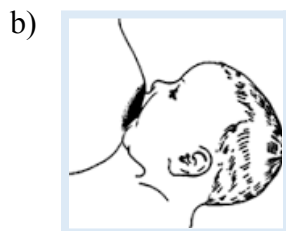
11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta



- c) No sé

14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

- a) De cuna



- b) Acostada



- c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

- a) Debajo del brazo



- b) Brazo opuesto



c) No sé

ANEXO 3. Formato de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada señora

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado “Efectividad de la consejería de enfermería en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del centro de salud Mirones, Lima-Perú, 2025”

El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de la consejería de enfermería en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del centro de salud Mirones, Lima-Perú, 2025

Si usted acepta participar en este estudio, se le solicitará que responda un cuestionario de entrada, que contiene preguntas sobre lactancia materna exclusiva, el cuestionario en sí le tomará aproximadamente 15 minutos, en mayo, junio o julio, según corresponda. Además, se aplicará una lista de cotejo para la evaluación de la mamada de su hijo. Posterior a ellos, se le brindará tres sesiones de consejería de enfermería sobre lactancia materna exclusiva que se acuerde a la disponibilidad. Finalmente de las tres sesiones, se le solicitará que responda un segundo cuestionario de salida que tomará aproximadamente 15 minutos.

La participación en esta actividad es voluntaria y no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental. Usted puede negarse a participar en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello, ni recibir ningún tipo de sanción.

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato, estos datos serán organizados con un número asignado a cada participante, la identidad de las madres se mantendrá completamente confidencial. Los datos estarán a cargo del investigador de este estudio para el posterior desarrollo de informes y publicaciones dentro de revistas científicas.

Si Usted no desea participar no implica sanción. Usted tiene el derecho a negarse a responder a preguntas concretas, también puede optar por retirarse de este estudio en cualquier momento y la información que hemos recogido será descartada del estudio y eliminada.

Cabe destacar que no existe ningún riesgo al participar de este estudio.

Cualquier pregunta que Usted desee hacer durante el proceso de investigación podrá contactar al Celular: 910777150, Correo electrónico: yemmy.santos@unmsm.edu.pe

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,....., acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación **“Efectividad de la consejería de enfermería en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del centro de salud Mirones, Lima-Perú, 2025”**, dirigida por Yemmy Eliane Santos Chinguel, Responsable de la investigación.

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación.

Declaro haber sido informado/a que mi participación no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna.

Declaro saber que la información entregada será **confidencial y anónima** y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones de cada participante de modo personal.

Declaro saber que la información que se obtenga será guardada por el investigador responsable y será utilizada sólo para este estudio.

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes.

Firma participante

Firma investigador

Fecha:

ANEXO 4. ROTAFOLIO “LACTANCIA DE AMOR”

 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA DE ENFERMERÍA

Lactancia de amor

Autora
Yemmy Eliane Santos Chinguel



I UNIDAD: Aspectos generales de lactancia materna



¿Qué es la lactancia materna?

El tipo de alimentación que recibe el bebé solo con leche materna en los primeros 6 meses de vida.



SE RECOMIENDA EVITAR:



¿Qué contiene la leche materna?

88 a 90%  AGUA

 Inmunoglobulinas


Carbohidratos
Grasas
Proteínas
Vitaminas y minerales
Hierro

¿Por qué es importante la lactancia materna exclusiva?

Método de alimentación:

- ✓ Más saludable
- ✓ Más seguro



Beneficia al bebé, familia y comunidad

II UNIDAD: ¿Cuáles son los beneficios?



Para el bebé

 Cantidades necesarias

 Apoyo en el crecimiento y desarrollo adecuado

 Presenta anticuerpos ante enfermedades como asma, alergias y diarreas

 Reduce el riesgo de muerte súbita, obesidad, anemia, diabetes, leucemia, cáncer infantil, colesterol alto e hipertensión

Para el bebé

 Mejor formación dental

 Menor prevalencia de gases y estreñimiento

 Favorece al desarrollo del habla

 Mejora del vínculo madre-hijo

Para la madre



Disminución de la hemorragia postparto



Disminución de la depresión post parto



Reduce el riesgo de desarrollar:

- Cáncer de ovario y mama
- Diabetes tipo 2
- Hipertensión
- Ataques cardíacos
- Osteoporosis
- Osteopenia
- Fractura de cadera
- Anemia

Para la madre



Contribuye a la seguridad de la madre y confianza



No tiene costo en la preparación y aplicación



Recupera su peso más rápido y disminuye el riesgo de obesidad

III UNIDAD: Tipos de lactancia



Materna exclusiva



De biberón



Diferida



Mixta



Relactancia



Relactar. Volver a dar el pecho a tu bebé

IV UNIDAD: Tipos de leche



Pre-calostro

Está acumulado en la zona alveolar en el tercer trimestre del embarazo

Calostro

- Producido durante los primeros 4 días después del nacimiento
- Escaso en cantidad pero denso en consistencia.
- Considerado como la primera "vacuna" del bebé porque presenta mayores sustancias inmunológicas
- Contiene un efecto laxante para la eliminación del meconio
- Disminuye la presencia de la ictericia del recién nacido



Leche de transición

Es producida entre el 4 a 15 días luego del parto, incrementado la cantidad y el volumen de la leche.

Leche madura

Se evidencia durante los primeros 6 meses posparto teniendo un aproximado de 700 a 900 ml/día.



Plus: leche de prematuro

Se encuentra en mujeres con partos prematuros.



Grasas
Sodio
Calorías
Inmunoglobulinas



V UNIDAD: ¿Cómo amamantar?



1. Madre en posición cómoda



2. Mano en forma de "C"



3. Nariz frente a pezón 4. Bebé abre bien la boca



Recuerde:

✓ Lactancia a libre demanda

✗ Lactancia con horarios



VI UNIDAD: Posiciones de lactancia



De cuna



Biológica



Acostada



Sandía



**Con el ala
opuesto**



De caballito



ANEXO 5. FICHAS RESUMEN

SESIÓN 1: Lactancia materna exclusiva y beneficios

¿Qué es?

Tipo de alimentación que recibe el bebé solo con leche materna en los 6 primeros meses de vida.



EVITAR:

- Agua
- Café, infusiones
- Gaseosas



¿QUÉ CONTIENE LA LECHE MATERNA?

¿Por qué es importante?

- Más saludable
- Más seguro
- Más beneficioso

BENEFICIOS

PARA EL BEBÉ

- Cantidad necesaria
- Apoyo en el crecimiento y desarrollo adecuado
- Rol protector contra asma, diarreas, obesidad infantil, meningitis, etc.
- Menos gases y estreñimiento.

PARA LA MADRE

- Disminuye hemorragia postparto
- Disminuye depresión postparto
- Reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario, diabetes, osteoporosis, etc.
- Ayuda a la pérdida de peso
- No tiene costo



SESIÓN 2: TIPOS DE LACTANCIA

LACTANCIA EXCLUSIVA

- Solo leche materna en los primeros 6 meses de vida
- Brinda protección ante enfermedades
- Brinda todos los requerimientos nutricionales
- Fortalece vínculo madre-hijo



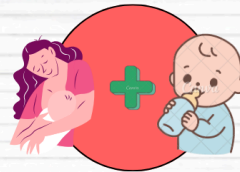
DE BIBERÓN

- Brindar tanto leche materna como leche en fórmula **por biberón**
- Se recomienda la fórmula solo por condiciones médicas



DIFERIDA

- Brinda leche materna extraída y que ha sido conservada.
- Una buena conservación mantiene los beneficios de la leche materna.
-

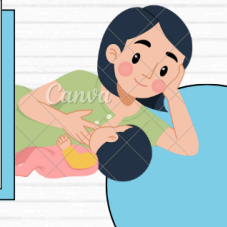


MIXTA

- Se alimenta al bebé con leche materna y fórmula infantil.
- Se recomienda esperar hasta los 6 semanas en caso se opte por esta lactancia.

RELACTANCIA

- Es el proceso en el cual la madre vuelve a dar de lactar a su hijo después de un período.
- Punto clave: **estimulación frecuente.**

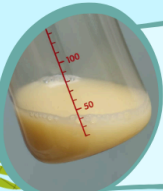


SESIÓN 3:

TIPOS DE LECHE

CALOSTRO

- Durante los primeros 4 días
- Escaso pero denso
- "Primera vacuna" por su gran aporte inmunológico
- Presenta efecto laxante para eliminar el meconio



DE TRANSICIÓN

- Producción de 4 a 15 días de nacido
- Incremento de volumen y cantidad de leche
- "Más succión" = "Más estimulación" = "Más producción de leche"



MADURA

- Desde los 15 días de nacido
- Mayor producción de leche materna de 700 a 900 ml/día.



PLUS

PRE CALOSTRO

Apartir del tercer trimestre del embarazo.



PREMATURO

Reconoce que el prematuro requiere más.

GRASAS
SODIO
CALORÍAS
INMUNOGLOBULINAS



¿CÓMO AMAMANTAR?

SESIÓN 4

MADRE EN POSICIÓN CÓMODA

La madre debe estar cómoda para que sea un **momento placentero**. Sin una posición cómoda, será estresante.



MANO EN "C"



NARIZ FRENTE A PEZÓN



BEBÉ ABRE BIEN LA BOCA



RECUERDA:

A LIBRE DEMANDA




POSICIONES DE LACTANCIA

SESIÓN 5

DECUBA

- Es la más utilizada



BIOLÓGICA



ACOSTADA



SANDÍA

- Recomendable en gemelos / mellizos



ALA OPUESTO

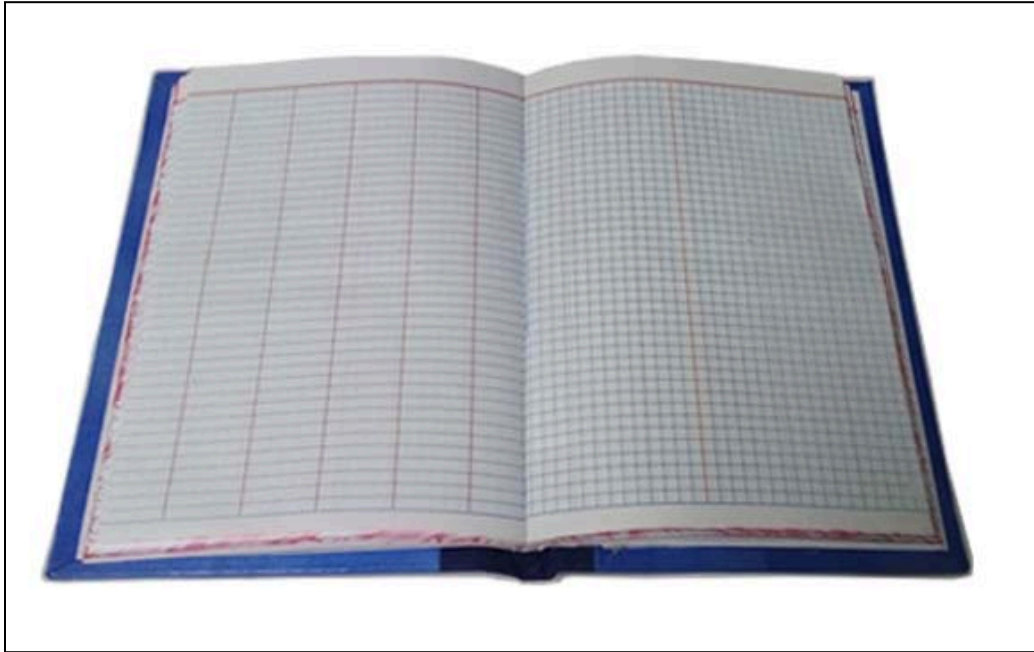


CABALLITO

ANEXO 6. MAQUETA DE SENO



ANEXO 7. BITÁCORA



Lima, 14 de mayo, 2025

Dra. Carmen Rocio Ricra Echevarria

Enfermera Docente de la E.P. Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez presentar a la señorita **Yemmy Eliane Santos Chinguel**, bachiller de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien viene desarrollando el proyecto de Investigación Titulado: **“Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025”** como parte del desarrollo de la tesis; por tal motivo, conocedora de su connotada experiencia profesional, me permito solicitar a usted tenga a bien participar como juez experto en la validación del instrumento de recolección de datos; para el efecto, se anexa el perfil básico del proyecto en mención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi consideración personal y agradecerle anticipadamente la atención que preste a la presente.

Atentamente.

Dra. Tula Margarita Espinoza Moreno

Docente Asesor

Código Docente 037435

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025

AUTORA

Bach. SANTOS CHINGUEL Yemmy Eliane

ASESORA

Dra. ESPINOZA MORENO Tula Margarita

Lima, Perú

2025

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Formulación del problema

¿Cuál es la efectividad del programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones en el año 2025?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar la efectividad de un programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en la mejora de los conocimientos y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones durante el año 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.
- Ejecutar el programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor”
- Describir el tipo de prácticas de lactancia materna exclusiva antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.

3. Estructura de la base teórica

3.1. Aspectos teórico-conceptuales del conocimiento

- Formación de los conocimientos
- Conocimientos sociales
- Conocimientos cotidianos
- Conocimientos en salud

3.2. Aspectos teóricos conceptuales sobre la práctica

- Importancia de la práctica
- Formación de la práctica
- Prácticas culturales
- Prácticas de la cotidianidad
- Los conocimientos en las prácticas

3.3. Aspectos teóricos conceptuales sobre lactancia materna

- La lactancia materna exclusiva en el mundo y el Perú
- Composición de la leche materna
- Importancia
- Beneficios Para el bebé
- Beneficios Para la madre
- Tipos de lactancia
- Tipos de leche
- Técnica de amamantamiento
- Posiciones de lactancia materna
- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal
- Lactancia materna en el hogar

3.4. Teóricas de enfermería

- Marco conceptual de las prácticas de lactancia materna de Dorothy E. Smith
- Modelo de promoción de la salud de Nola Pender
- Adaptación del rol materno de Ramona Mercer

4. Instrumentos de recolección de datos

4.1. Instrumento A.

CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD MIRONES, 2025

1. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

2. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

3. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

3. La leche materna tiene más del 80% de agua.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

a) Verdadero

b) Falso

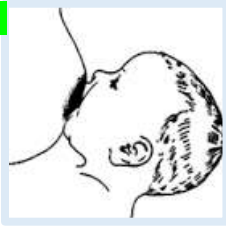
c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta

a)



b)



c) No sé

14. Se brinda lactancia materna exclusiva con horarios establecidos.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

a) De cuna



b) Acostada



c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo



b) Brazo opuesto



c) No sé

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento A.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.					X	
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.					X	
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.					X	
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.					X	
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.					X	
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.			X			
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.					X	
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.				X		
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.					X	
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.					X	

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.			X			
12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.					X	
13. Marque cuál es la técnica correcta					X	
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.				X		
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.					X	
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.					X	
17. Señale la posición que más se utiliza.				X		
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.				X		

Nombre del juez-experto:

Cargo: Docente de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma

Fecha: 05/06/2025

Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA
Dra. Carmen Rocío Ricra Echevarría
DOCENTE

4.2. Instrumento B.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA*

Nombre de la madre: _____

Fecha: _____

Nombre del bebé: _____

Edad del bebé: _____

Signos de que la lactancia materna funciona bien	Signos de una posible dificultad
Madre: ● Luce saludable ● Relajada y cómoda ● Signos de apego entre madre y bebé	Madre: ● Luce enferma o deprimida ● Luce tensa e incómoda ● No EXISTE contacto visual madre y bebé
Bebé: ● Luce saludable ● Calmado y relajado ● Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	Bebé: ● Luce somnolienta/o y enfermera/o ● Inquieto y/o llorando ● No alcanza ni busca el pecho
Pechos: ● Pechos blandos, piel luce sana ● No dolor ni incomodidad ● Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	Pechos: ● Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados ● Pechos o pezones dolorosos ● Pecho sostenido con dedos en la areola ● Pezones aplastados, deformados, después de la mamada
Posición de la o el bebé: ● Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados ● Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre ● Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	Posición de la o el bebé: ● Cuello y cabeza torcidos para mamar ● Bebé separado de la madre ● Solo apoyados la cabeza y cuello ● Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón
Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola sobre el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé bien abierta ● Labio inferior volteado hacia afuera ● Mentón de la o el bebé toca el pecho	Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola debajo el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé no está abierta ● Labios hacia adelante o hacia adentro ● Mentón de la o el bebé no toca el pecho
Succión: ● Mamadas lentas y profundas, con pausas ● Mejillas redondeadas cuando succiona ● La o el bebé suelta el pecho cuando termina ● Madre nota signos del reflejo de oxitocina	Succión: ● Mamadas rápidas y superficiales ● Mejillas chupadas hacia adentro ● La madre retira a la o el bebé del pecho ● La madre no nota signos del reflejo de oxitocina
NOTAS:	

*MINSA (2015). Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna. Disponible en:
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento B.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: madre					x	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: bebé					x	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: pechos					x	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: posición de la o el bebé					x	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: agarre de la o el bebé al pecho					x	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: succión					x	

Nombre del juez-experto:

Cargo: Docente de la Universidad Nacional Autónoma
Altoandina de Tarma

Fecha: 05/06/2025

Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE Tarma
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA
Dra. Carmen Rocío Ricra Echevarría
DOCENTE

Lima, 23 de agosto, 2023

Dra. Edna Ramírez

Profesora Principal del Departamento Académico de Enfermería
Facultad de Medicina - UNMSM

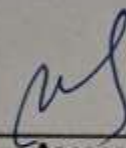
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez presentar a la señorita **Yemmy Eliane Santos Chinguel**, estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien viene desarrollando el proyecto de Investigación Titulado: **"Efectividad de la consejería de enfermería en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas de un centro de salud en Lima Metropolitana, 2023"** como parte de la asignatura Indagación Científica en Enfermería II; por tal motivo, conocedora de su connotada experiencia profesional, me permito solicitar a usted tenga a bien participar como juez experto en la validación del instrumento de recolección de datos; para el efecto, se anexa el perfil del proyecto en mención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi consideración personal y agradecerle anticipadamente la atención que preste a la presente.

Atentamente.



Asesora

Mg. Mistral Ena Carhuapoma Acosta

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas de un centro de salud en Lima Metropolitana, 2023

ASIGNATURA

Indagación Científica en Enfermería I

ESTUDIANTE

Yemmy Eliane Santos Chinguel

ASESORA

Mg. Mistral Ena Carhuapoma Acosta

Lima, Perú

2023

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Formulación del problema

¿Cuál es la efectividad de la consejería de enfermería en el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir, 2023?”

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar la efectividad de la consejería de enfermería en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir, 2023.

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva previo a la ejecución de la consejería de enfermería.
- Ejecutar la consejería de enfermería sobre la lactancia materna exclusiva a las madres.
- Identificar el incremento del nivel de conocimientos sobre lactancia materna exclusiva posterior a la ejecución de la consejería de enfermería.

3. Estructura de la base teórica

3.1. Aspectos teóricos conceptuales sobre la lactancia materna

- Definición de la lactancia materna exclusiva
- Composición de leche materna
- Importancia
- Beneficios para el bebé
- Beneficios para la madre
- Tipos de lactancia
- Tipos de leche
- Técnica de amamantamiento
- Posiciones de lactancia materna
- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal
- Lactancia materna en el hogar

3.2. La consejería en la lactancia materna

- Definición
- Características
- Metodología de la consejería de la lactancia materna
- Habilidades de comunicación para la consejería de lactancia materna
- Consejería con enfoque intercultural

3.3. Rol del profesional de Enfermería

4. Instrumento de recolección de datos

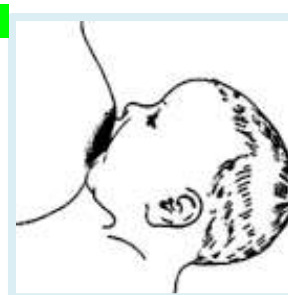
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
3. El componente más abundante de la leche materna es el agua.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé
5. La lactancia materna exclusiva previene enfermedades en el bebé como el asma.
 - a) Verdadero
 - b) Falso
 - c) No sé

6. Uno de los beneficios de la lactancia materna en la madre es la prevención de la hepatitis.
- a) Verdadero
b) Falso
c) No sé
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.
- a) Verdadero**
b) Falso
c) No sé
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.
- a) Verdadero**
b) Falso
c) No sé
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.
- a) Verdadero
b) Falso
c) No sé
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.
- a) Verdadero**
b) Falso
c) No sé
11. La cantidad de leche de transición producida es de 300 a 600 mililitros.
- a) Verdadero
b) Falso
c) No sé
12. La cantidad de leche madura producida es de 700 a 900 mililitros.
- a) Verdadero**
b) Falso
c) No sé
13. Marque cuál es la técnica correcta

a)



b)



c) No sé

14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.
- a) Verdadero
b) Falso
c) No sé
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.
- a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es bajo peso en el bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

17. Señale la posición que más se utiliza.

a) De cuna



b) Acostada



c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo



a) Brazo opuesto



b) No sé

5. Formato de informe de validez del instrumento

INFORME DE JUCIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.					x	
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.					x	
3. El componente más abundante de la leche materna es el agua.					x	
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.					x	
5. La lactancia materna exclusiva previene enfermedades en el bebé como el asma.					x	
6. Uno de los beneficios de la lactancia materna en la madre es la prevención de la hepatitis.					x	
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.					x	
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.					x	
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.					x	
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.					x	

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.					x	
12. La cantidad de leche de transición producida es de 700 a 900 mililitros.					x	
13. Marque cuál es la técnica correcta					x	
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.					x	
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.					x	
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es bajo peso en el bebé.					x	
17. Señale la posición que más se utiliza.					x	
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.					x	

Nombre del juez-experto: EDNA RAMIREZ MIRANDA Cargo:

DOCENTE

Fecha: Lima, 29 de agosto del 2023

Firma

Lima, 8 de mayo, 2025

Lic. Luz Chuje

Enfermera encargada del servicio de Crecimiento y Desarrollo del establecimiento de salud
Zárate

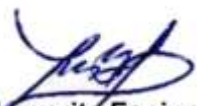
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez presentar a la señorita **Yemmy Eliane Santos Chinguel**, bachiller de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien viene desarrollando el proyecto de Investigación Titulado: **“Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025”** como parte del desarrollo de la tesis; por tal motivo, conocedora de su connotada experiencia profesional, me permito solicitar a usted tenga a bien participar como juez experto en la validación del instrumento de recolección de datos; para el efecto, se anexa el perfil básico del proyecto en mención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi consideración personal y agradecerle anticipadamente la atención que preste a la presente.

Atentamente.


Dra. Tula Margarita Espinoza Moreno
Docente Asesor
Código Docente 037435

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025

AUTORA

Bach. SANTOS CHINGUEL Yemmy Eliane

ASESORA

Dra. ESPINOZA MORENO Tula Margarita

Lima, Perú

2025

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Formulación del problema

¿Cuál es la efectividad del programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones en el año 2025?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar la efectividad de un programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en la mejora de los conocimientos y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones durante el año 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.
- Ejecutar el programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor”
- Describir el tipo de prácticas de lactancia materna exclusiva antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.

3. Estructura de la base teórica

3.1. Aspectos teórico-conceptuales del conocimiento

- Formación de los conocimientos
- Conocimientos sociales
- Conocimientos cotidianos
- Conocimientos en salud

3.2. Aspectos teóricos conceptuales sobre la práctica

- Importancia de la práctica
- Formación de la práctica
- Prácticas culturales
- Prácticas de la cotidianidad
- Los conocimientos en las prácticas

3.3. Aspectos teóricos conceptuales sobre lactancia materna

- La lactancia materna exclusiva en el mundo y el Perú
- Composición de la leche materna
- Importancia
- Beneficios Para el bebé
- Beneficios Para la madre
- Tipos de lactancia
- Tipos de leche
- Técnica de amamantamiento
- Posiciones de lactancia materna
- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal
- Lactancia materna en el hogar

3.4. Teóricas de enfermería

- Marco conceptual de las prácticas de lactancia materna de Dorothy E. Smith
- Modelo de promoción de la salud de Nola Pender
- Adaptación del rol materno de Ramona Mercer

4. Instrumentos de recolección de datos

4.1. Instrumento A.

CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD MIRONES, 2025

1. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

2. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

3. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

3. La leche materna tiene más del 80% de agua.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

a) Verdadero

b) Falso

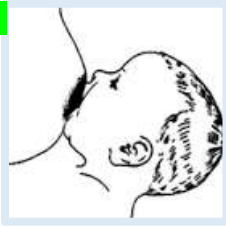
c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta

a)



b)



c) No sé

14. Se brinda lactancia materna exclusiva con horarios establecidos.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

a) De cuna



b) Acostada



c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo



b) Brazo opuesto



c) No sé

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento A.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.					X	
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.					X	
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.					X	
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.					X	
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.					X	
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.					X	
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.					X	
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.			X			Usar términos de acuerdo al nivel de educación de la madre o población al que va dirigido.
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.			X			Usar términos de acuerdo al nivel de educación de la madre o población al que va dirigido.
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.			X			Usar términos de acuerdo al nivel de educación de la madre o población al que va dirigido.

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.			X		Usar términos de acuerdo al nivel de educación de la madre o población al que va dirigido.
12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.			X		Usar términos de acuerdo al nivel de educación de la madre o población al que va dirigido.
13. Marque cuál es la técnica correcta				X	
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.				X	
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.				X	
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.				X	
17. Señale la posición que más se utiliza.				X	
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.				X	

Nombre del juez-experto: LUZ ARMINDA CHUJE

AHUANARI

Cargo: RESPONSABLE DE CRED Y COMPONENTE

NEONATAL

Fecha: 15/5/25

Firma:



LUZ ARMINDA CHUJE
LIC. EN ENFERMERIA
C.E.P. 85515

4.2. Instrumento B.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA*

Nombre de la madre: _____

Fecha: _____

Nombre del bebé: _____

Edad del bebé: _____

Signos de que la lactancia materna funciona bien	Signos de una posible dificultad
Madre: ● Luce saludable ● Relajada y cómoda ● Signos de apego entre madre y bebé	Madre: ● Luce enferma o deprimida ● Luce tensa e incómoda ● No EXISTE contacto visual madre y bebé
Bebé: ● Luce saludable ● Calmado y relajado ● Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	Bebé: ● Luce somnolienta/o y enfermera/o ● Inquieto y/o llorando ● No alcanza ni busca el pecho
Pechos: ● Pechos blandos, piel luce sana ● No dolor ni incomodidad ● Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	Pechos: ● Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados ● Pechos o pezones dolorosos ● Pecho sostenido con dedos en la areola ● Pezones aplastados, deformados, después de la mamada
Posición de la o el bebé: ● Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados ● Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre ● Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	Posición de la o el bebé: ● Cuello y cabeza torcidos para mamar ● Bebé separado de la madre ● Solo apoyados la cabeza y cuello ● Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón
Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola sobre el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé bien abierta ● Labio inferior volteado hacia afuera ● Mentón de la o el bebé toca el pecho	Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola debajo el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé no está abierta ● Labios hacia adelante o hacia adentro ● Mentón de la o el bebé no toca el pecho
Succión: ● Mamadas lentas y profundas, con pausas ● Mejillas redondeadas cuando succiona ● La o el bebé suelta el pecho cuando termina ● Madre nota signos del reflejo de oxitocina	Succión: ● Mamadas rápidas y superficiales ● Mejillas chupadas hacia adentro ● La madre retira a la o el bebé del pecho ● La madre no nota signos del reflejo de oxitocina
NOTAS:	

*MINSA (2015). Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna. Disponible en:
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento B.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: madre					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: bebé					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: pechos					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: posición de la o el bebé					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: agarre de la o el bebé al pecho					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: succión					X	

Nombre del juez-experto: LUZ ARMINDA CHUJE AHUANARI

Cargo: RESPONSABLE DE CRED Y COMPONENTE
NEONATAL

Fecha: 15/5/25

Firma:




Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas de un centro de salud en Lima Metropolitana, 2023

ASIGNATURA

Indagación Científica en Enfermería I

ESTUDIANTE

Yemmy Eliane Santos Chinguel ✓

ASESORA

Mg. Mistral Ena Carhuapoma Acosta

Lima, Perú

2023

5. Formato de informe de validez del instrumento

INFORME DE JUCIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

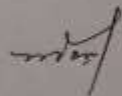
Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.					✓	
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.			✓			
3. El componente más abundante de la leche materna es el agua.			✓			
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.				✓		
5. La lactancia materna exclusiva previene enfermedades en el bebé como el asma.				✓		
6. Uno de los beneficios de la lactancia materna en la madre es la prevención de la hepatitis.				✓		
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.			✓			
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.				✓		
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.				✓		
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.			✓			

La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.			✓		
12. La cantidad de leche de transición producida es de 700 a 900 mililitros.			✓		nhace
13. Marque cuál es la técnica correcta			✓		nhace según lo observo
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.			✓		si
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.			✓		si
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es bajo peso en el bebé.				✓	si
17. Señale la posición que más se utiliza.			✓		si
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.			✓		si

Nombre del juez-experto: martha Vera m. Cargo: Profesora Principal
T.C.

Fecha: Lima, 31 de 08 del 2023

Firma



Lima, 7 de mayo, 2025

Lic. Norma

Enfermera encargada del servicio de Crecimiento y Desarrollo del establecimiento de salud Breña

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez presentar a la señorita **Yemmy Eliane Santos Chinguel**, bachiller de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien viene desarrollando el proyecto de Investigación Titulado: **“Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025”** como parte del desarrollo de la tesis; por tal motivo, conocedora de su connotada experiencia profesional, me permito solicitar a usted tenga a bien participar como juez experto en la validación del instrumento de recolección de datos; para el efecto, se anexa el perfil básico del proyecto en mención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi consideración personal y agradecerle anticipadamente la atención que preste a la presente.

Atentamente.


Dra. Tula Margarita Espinoza Moreno
Docente Asesor
Código Docente 037435

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025

AUTORA

Bach. SANTOS CHINGUEL Yemmy Eliane

ASESORA

Dra. ESPINOZA MORENO Tula Margarita

Lima, Perú

2025

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Formulación del problema

¿Cuál es la efectividad del programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones en el año 2025?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar la efectividad de un programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en la mejora de los conocimientos y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones durante el año 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.
- Ejecutar el programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor”
- Describir el tipo de prácticas de lactancia materna exclusiva antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.

3. Estructura de la base teórica

3.1. Aspectos teórico-conceptuales del conocimiento

- Formación de los conocimientos
- Conocimientos sociales
- Conocimientos cotidianos
- Conocimientos en salud

3.2. Aspectos teóricos conceptuales sobre la práctica

- Importancia de la práctica
- Formación de la práctica
- Prácticas culturales
- Prácticas de la cotidianidad
- Los conocimientos en las prácticas

3.3. Aspectos teóricos conceptuales sobre lactancia materna

- La lactancia materna exclusiva en el mundo y el Perú
- Composición de la leche materna
- Importancia
- Beneficios Para el bebé
- Beneficios Para la madre
- Tipos de lactancia
- Tipos de leche
- Técnica de amamantamiento
- Posiciones de lactancia materna
- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal
- Lactancia materna en el hogar

3.4. Teóricas de enfermería

- Marco conceptual de las prácticas de lactancia materna de Dorothy E. Smith
- Modelo de promoción de la salud de Nola Pender
- Adaptación del rol materno de Ramona Mercer

4. Instrumentos de recolección de datos

4.1. Instrumento A.

CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD MIRONES, 2025

1. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

2. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

3. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

3. La leche materna tiene más del 80% de agua.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

a) Verdadero

b) Falso

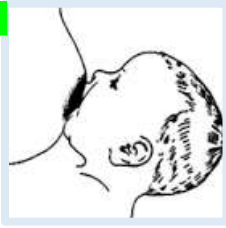
c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta

a)



b)



c) No sé

14. Se brinda lactancia materna exclusiva con horarios establecidos.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

a) De cuna



b) Acostada



c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo



b) Brazo opuesto



c) No sé

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento A.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.				x		
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.				x		
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.			x			
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.					x	
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.					x	
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.				x		
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.				x		
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.			x			El calostro es el primer alimento que recibe.....
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.				x		
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.		x				la leche de transición no es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé, sino que es la leche que se produce después del calostro y antes de la leche madura

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.				x		
12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.					x	
13. Marque cuál es la técnica correcta					x	
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.				x		
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.				x		
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.					x	
17. Señale la posición que más se utiliza.			x			Recomiendo colocar mas alternativas para la posicion adecuada de la lactancia materna
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.			x			

Nombre del juez-experto: Norma Elizabeth Quinto Arrieta

Cargo: crecimineto y desarrollo de C.S. Beña

Fecha: 5-06.-2025

Firma:



4.2. Instrumento B.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA*

Nombre de la madre: _____

Fecha: _____

Nombre del bebé: _____

Edad del bebé: _____

Signos de que la lactancia materna funciona bien	Signos de una posible dificultad
Madre: ● Luce saludable ● Relajada y cómoda ● Signos de apego entre madre y bebé	Madre: ● Luce enferma o deprimida ● Luce tensa e incómoda ● No EXISTE contacto visual madre y bebé
Bebé: ● Luce saludable ● Calmado y relajado ● Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	Bebé: ● Luce somnolienta/o y enfermera/o ● Inquieto y/o llorando ● No alcanza ni busca el pecho
Pechos: ● Pechos blandos, piel luce sana ● No dolor ni incomodidad ● Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	Pechos: ● Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados ● Pechos o pezones dolorosos ● Pecho sostenido con dedos en la areola ● Pezones aplastados, deformados, después de la mamada
Posición de la o el bebé: ● Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados ● Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre ● Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	Posición de la o el bebé: ● Cuello y cabeza torcidos para mamar ● Bebé separado de la madre ● Solo apoyados la cabeza y cuello ● Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón
Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola sobre el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé bien abierta ● Labio inferior volteado hacia afuera ● Mentón de la o el bebé toca el pecho	Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola debajo el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé no está abierta ● Labios hacia adelante o hacia adentro ● Mentón de la o el bebé no toca el pecho
Succión: ● Mamadas lentas y profundas, con pausas ● Mejillas redondeadas cuando succiona ● La o el bebé suelta el pecho cuando termina ● Madre nota signos del reflejo de oxitocina	Succión: ● Mamadas rápidas y superficiales ● Mejillas chupadas hacia adentro ● La madre retira a la o el bebé del pecho ● La madre no nota signos del reflejo de oxitocina
NOTAS:	

*MINSA (2015). Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna. Disponible en:
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento B.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: madre			X			Recomiendo la ficha de observacion lleve imagenes que permita mejor la observación
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: bebé			X			Recomiendo la ficha de observacion lleve imagenes que permita mejor la observación
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: pechos			X			Considerar los tipos de pezones, ya que ello tambien puede dificultar la lactancia materna Recomiendo la ficha de observacion lleve imagenes que permita mejor la observación
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: posición de la o el bebé				x		Recomiendo la ficha de observacion lleve imagenes que permita mejor la observación
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: agarre de la o el bebé al pecho				x		Recomiendo la ficha de observacion lleve imagenes que permita mejor la observación
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: succión			X			Recomiendo la ficha de observacion lleve imagenes que permita mejor la observación

Nombre del juez-experto: Norma Elizabeth Quinto Arrieta

Cargo: Crecimiento y desarrollo C.s. Breña

Fecha: 05-06-2025

Firma:



Lima, 7 de mayo, 2025

Lic. Verisa Salazar

Enfermera Jefe del servicio de Crecimiento y Desarrollo del establecimiento de salud Laura
Caller

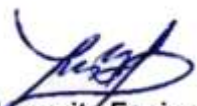
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez presentar a la señorita **Yemmy Eliane Santos Chinguel**, bachiller de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien viene desarrollando el proyecto de Investigación Titulado: **“Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025”** como parte del desarrollo de la tesis; por tal motivo, conocedora de su connotada experiencia profesional, me permito solicitar a usted tenga a bien participar como juez experto en la validación del instrumento de recolección de datos; para el efecto, se anexa el perfil básico del proyecto en mención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi consideración personal y agradecerle anticipadamente la atención que preste a la presente.

Atentamente.


Dra. Tula Margarita Espinoza Moreno
Docente Asesor
Código Docente 037435

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025

AUTORA

Bach. SANTOS CHINGUEL Yemmy Eliane

ASESORA

Dra. ESPINOZA MORENO Tula Margarita

Lima, Perú

2025

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Formulación del problema

¿Cuál es la efectividad del programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones en el año 2025?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar la efectividad de un programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en la mejora de los conocimientos y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones durante el año 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.
- Ejecutar el programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor”
- Describir el tipo de prácticas de lactancia materna exclusiva antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.

3. Estructura de la base teórica

3.1. Aspectos teórico-conceptuales del conocimiento

- Formación de los conocimientos
- Conocimientos sociales
- Conocimientos cotidianos
- Conocimientos en salud

3.2. Aspectos teóricos conceptuales sobre la práctica

- Importancia de la práctica
- Formación de la práctica
- Prácticas culturales
- Prácticas de la cotidianidad
- Los conocimientos en las prácticas

3.3. Aspectos teóricos conceptuales sobre lactancia materna

- La lactancia materna exclusiva en el mundo y el Perú
- Composición de la leche materna
- Importancia
- Beneficios Para el bebé
- Beneficios Para la madre
- Tipos de lactancia
- Tipos de leche
- Técnica de amamantamiento
- Posiciones de lactancia materna
- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal
- Lactancia materna en el hogar

3.4. Teóricas de enfermería

- Marco conceptual de las prácticas de lactancia materna de Dorothy E. Smith
- Modelo de promoción de la salud de Nola Pender
- Adaptación del rol materno de Ramona Mercer

4. Instrumentos de recolección de datos

4.1. Instrumento A.

CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD MIRONES, 2025

1. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

2. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

3. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

3. La leche materna tiene más del 80% de agua.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

a) Verdadero

b) Falso

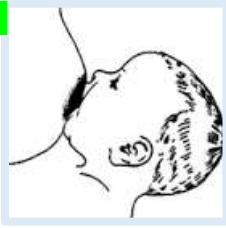
c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta

a)



b)



c) No sé

14. Se brinda lactancia materna exclusiva con horarios establecidos.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

a) De cuna



b) Acostada



c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo



b) Brazo opuesto



c) No sé

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento A.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.				X		
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.				X		
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.			X			
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.				X		
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.					X	
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.				X		
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.					X	
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.					X	
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.				X		
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.				X		

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.				X		
12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.				X		
13. Marque cuál es la técnica correcta					X	
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.					X	
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.				X		
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.					X	
17. Señale la posición que más se utiliza.				X		
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.				X		

Nombre del juez-experto: Lic. Verisa Garay Salazar

Cargo: Enfermera del C.S Laura Caller

Fecha: 08/05/2025

Firma:


 PERU MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NOROCCIDENTE

 LIC. VERISA GARAY SALAZAR
 LIC. EN ENFERMERIA C.S. LAURA CALLER
 C.M.P. 07720

4.2. Instrumento B.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA*

Nombre de la madre: _____

Fecha: _____

Nombre del bebé: _____

Edad del bebé: _____

Signos de que la lactancia materna funciona bien	Signos de una posible dificultad
Madre: ● Luce saludable ● Relajada y cómoda ● Signos de apego entre madre y bebé	Madre: ● Luce enferma o deprimida ● Luce tensa e incómoda ● No EXISTE contacto visual madre y bebé
Bebé: ● Luce saludable ● Calmado y relajado ● Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	Bebé: ● Luce somnolienta/o y enfermera/o ● Inquieto y/o llorando ● No alcanza ni busca el pecho
Pechos: ● Pechos blandos, piel luce sana ● No dolor ni incomodidad ● Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	Pechos: ● Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados ● Pechos o pezones dolorosos ● Pecho sostenido con dedos en la areola ● Pezones aplastados, deformados, después de la mamada
Posición de la o el bebé: ● Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados ● Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre ● Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	Posición de la o el bebé: ● Cuello y cabeza torcidos para mamar ● Bebé separado de la madre ● Solo apoyados la cabeza y cuello ● Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón
Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola sobre el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé bien abierta ● Labio inferior volteado hacia afuera ● Mentón de la o el bebé toca el pecho	Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola debajo el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé no está abierta ● Labios hacia adelante o hacia adentro ● Mentón de la o el bebé no toca el pecho
Succión: ● Mamadas lentas y profundas, con pausas ● Mejillas redondeadas cuando succiona ● La o el bebé suelta el pecho cuando termina ● Madre nota signos del reflejo de oxitocina	Succión: ● Mamadas rápidas y superficiales ● Mejillas chupadas hacia adentro ● La madre retira a la o el bebé del pecho ● La madre no nota signos del reflejo de oxitocina
NOTAS:	

*MINSA (2015). Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna. Disponible en:
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento B.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: madre				X		
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: bebé				X		
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: pechos				X		
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: posición de la o el bebé				X		
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: agarre de la o el bebé al pecho				X		
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: succión				X		

Nombre del juez-experto: Lic. Verisa Garay Salazar

Cargo: Enfermera del C.S Laura Caller

Fecha: 08/05/2025

Firma:


.....
LIC. VERISA GARAY SALAZAR
LIC. EN ENFERMERIA C.S. LAURA CALLER
C.N.P. 87728

Lima, 7 de mayo, 2025

Lic. Yackelin Virginia Suazo Ramirez

Enfermera encargada del servicio de Crecimiento y Desarrollo del establecimiento de salud Mirones

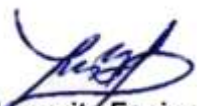
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo, y a la vez presentar a la señorita **Yemmy Eliane Santos Chinguel**, bachiller de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien viene desarrollando el proyecto de Investigación Titulado: **“Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025”** como parte del desarrollo de la tesis; por tal motivo, conocedora de su connotada experiencia profesional, me permito solicitar a usted tenga a bien participar como juez experto en la validación del instrumento de recolección de datos; para el efecto, se anexa el perfil básico del proyecto en mención.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi consideración personal y agradecerle anticipadamente la atención que preste a la presente.

Atentamente.


Dra. Tula Margarita Espinoza Moreno
Docente Asesor
Código Docente 037435

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería**



PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Efectividad de la consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones, Lima-Perú, 2025

AUTORA

Bach. SANTOS CHINGUEL Yemmy Eliane

ASESORA

Dra. ESPINOZA MORENO Tula Margarita

Lima, Perú

2025

PERFIL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Formulación del problema

¿Cuál es la efectividad del programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en los conocimientos y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas usuarias del Centro de Salud Mirones en el año 2025?

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Determinar la efectividad de un programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor” en la mejora de los conocimientos y la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Centro de Salud Mirones durante el año 2025.

2.2. Objetivos específicos

- Evaluar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.
- Ejecutar el programa de consejería de enfermería “Lactancia de amor”
- Describir el tipo de prácticas de lactancia materna exclusiva antes y después de la intervención del programa de consejería de enfermería.

3. Estructura de la base teórica

3.1. Aspectos teórico-conceptuales del conocimiento

- Formación de los conocimientos
- Conocimientos sociales
- Conocimientos cotidianos
- Conocimientos en salud

3.2. Aspectos teóricos conceptuales sobre la práctica

- Importancia de la práctica
- Formación de la práctica
- Prácticas culturales
- Prácticas de la cotidianidad
- Los conocimientos en las prácticas

3.3. Aspectos teóricos conceptuales sobre lactancia materna

- La lactancia materna exclusiva en el mundo y el Perú
- Composición de la leche materna
- Importancia
- Beneficios Para el bebé
- Beneficios Para la madre
- Tipos de lactancia
- Tipos de leche
- Técnica de amamantamiento
- Posiciones de lactancia materna
- Lactancia materna en el embarazo y la atención prenatal
- Lactancia materna en el hogar

3.4. Teóricas de enfermería

- Marco conceptual de las prácticas de lactancia materna de Dorothy E. Smith
- Modelo de promoción de la salud de Nola Pender
- Adaptación del rol materno de Ramona Mercer

4. Instrumentos de recolección de datos

4.1. Instrumento A.

CUESTIONARIO PARA MADRES PRIMÍPARAS DEL CENTRO DE SALUD MIRONES, 2025

1. PRESENTACIÓN

Buenos días, señora. Soy Yemmy Santos, bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le solicita la colaboración en el siguiente cuestionario para indagar sobre el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva. El cuestionario es totalmente anónimo y confidencial. De antemano, agradezco su valiosa participación.

2. DATOS GENERALES

1. Edad: años

2. Grado de instrucción:

Ninguno ()

Primaria incompleta ()

Primaria completa ()

Secundaria incompleta ()

Secundaria completa ()

Superior técnico ()

Superior universitario ()

3. INSTRUCCIONES:

Lea con atención las preguntas y marque con una x el enunciado que usted considere correcto. Solo debe marcar una opción.

IV. CONTENIDO

1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

3. La leche materna tiene más del 80% de agua.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.

a) Verdadero

b) Falso

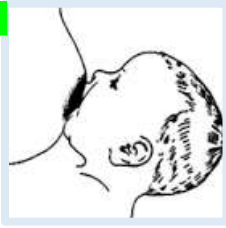
c) No sé

13. Marque cuál es la técnica correcta

a)



b)



c) No sé

14. Se brinda lactancia materna exclusiva con horarios establecidos.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.

a) Verdadero

b) Falso

c) No sé

17. Señale la posición que más es utilizada.

a) De cuna



b) Acostada



c) No sé

18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.

a) Debajo del brazo



b) Brazo opuesto



c) No sé

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento A.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es el tipo de alimentación que recibe el bebé con leche materna y fórmula durante los primeros 6 meses de vida.					X	
2. La lactancia materna exclusiva es hasta los 8 meses.					X	
3. La leche materna tiene más del 80% de agua.					X	
4. Uno de los beneficios de la leche materna en el bebé es un adecuado crecimiento y desarrollo.					X	
5. La lactancia materna tiene anticuerpos que disminuye el riesgo de enfermedades como el asma, diarreas, etc.					X	
6. La lactancia materna exclusiva ayuda a la recuperación lenta después del parto.					X	
7. La lactancia materna exclusiva reduce los casos de cáncer de ovario y de mama.					X	
8. El calostro es el primer tipo de leche materna que el bebé recibe en la lactancia materna.					X	
9. El calostro es considerado como el primer laxante del bebé.					X	
10. La leche de transición es el segundo tipo de leche que se le brinda al bebé.					X	

11. La leche de transición es producida desde el día 1 al 10 postparto.				X		
12. La producción de la leche madura es mayor que la producción de calostro.				X		
13. Marque cuál es la técnica correcta					X	
14. Se brinda lactancia materna con horarios establecidos.					X	
15. Durante la lactancia materna es normal que la madre presente dolor.					X	
16. Una de las consecuencias de la mala técnica de lactancia es el bajo peso en el bebé.					X	
17. Señale la posición que más se utiliza.					X	
18. Señale la posición recomendada en caso de mellizos y/o gemelos.					X	

Nombre del juez-experto:

Cargo: Enfermera

Fecha: 5 de Junio 2025

Firma:

4.2. Instrumento B.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA MAMADA*

Nombre de la madre: _____

Fecha: _____

Nombre del bebé: _____

Edad del bebé: _____

Signos de que la lactancia materna funciona bien	Signos de una posible dificultad
Madre: ● Luce saludable ● Relajada y cómoda ● Signos de apego entre madre y bebé	Madre: ● Luce enferma o deprimida ● Luce tensa e incómoda ● No EXISTE contacto visual madre y bebé
Bebé: ● Luce saludable ● Calmado y relajado ● Alcanza o busca el pecho si tiene hambre	Bebé: ● Luce somnolienta/o y enfermera/o ● Inquieto y/o llorando ● No alcanza ni busca el pecho
Pechos: ● Pechos blandos, piel luce sana ● No dolor ni incomodidad ● Pecho bien sostenido con dedos lejos del pezón	Pechos: ● Pechos lucen rojos, hinchados y fisurados ● Pechos o pezones dolorosos ● Pecho sostenido con dedos en la areola ● Pezones aplastados, deformados, después de la mamada
Posición de la o el bebé: ● Cabeza y cuerpo de la o el bebé alineados ● Bebé sostenido cerca del cuerpo de la madre ● Todo el cuerpo de la o el bebé apoyado. Al aproximarse la o el bebé al pecho, nariz apunta hacia el pezón	Posición de la o el bebé: ● Cuello y cabeza torcidos para mamar ● Bebé separado de la madre ● Solo apoyados la cabeza y cuello ● Al aproximarse a la o el bebé al pecho, el labio inferior/mentón está hacia el pezón
Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola sobre el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé bien abierta ● Labio inferior volteado hacia afuera ● Mentón de la o el bebé toca el pecho	Agarre de la o el bebé al pecho: ● Más areola debajo el labio superior de la o el bebé ● Boca de la o el bebé no está abierta ● Labios hacia adelante o hacia adentro ● Mentón de la o el bebé no toca el pecho
Succión: ● Mamadas lentas y profundas, con pausas ● Mejillas redondeadas cuando succiona ● La o el bebé suelta el pecho cuando termina ● Madre nota signos del reflejo de oxitocina	Succión: ● Mamadas rápidas y superficiales ● Mejillas chupadas hacia adentro ● La madre retira a la o el bebé del pecho ● La madre no nota signos del reflejo de oxitocina
NOTAS:	

*MINSA (2015). Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna. Disponible en:
<https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>

Formato de informe de validez del instrumento del instrumento B.

INFORME DE JUICIO DE EXPERTO

Indicaciones: Marque con una equis según corresponda, valorando la pertinencia, claridad y redacción de cada ítem o pregunta según la siguiente escala:

1= Inaceptable 2 = Deficiente 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente

Ítem	Evaluación					Observación
	1	2	3	4	5	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: madre					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: bebé					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: pechos					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: posición de la o el bebé					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: agarre de la o el bebé al pecho					X	
Lactancia materna funciona bien / posible dificultad: succión					X	

Nombre del juez-experto:

Cargo:

Fecha:

Firma: